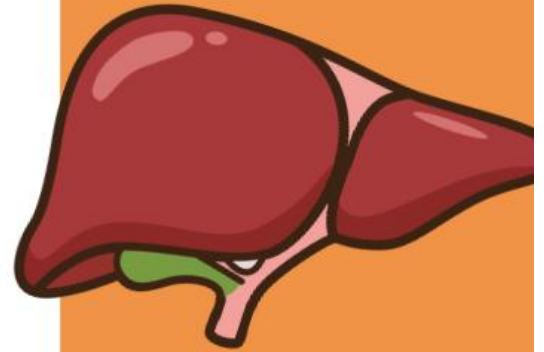


אבחנה מבדלת - Zang Fu

足厥陰肝經

THE LIVER CHANNEL
OF FOOT JUEYIN



דפוסים - הכבד

הכבד תפקודים:

- הוא מאחסן דם
- הוא מבטיח זרימה חלקה של צ'י
- הוא שולט בגידים
- הוא מתבטא בציפורניים
- הוא נפתח לעיניים
- הוא שולט בדמעות
- הוא מאכלס את הנשמה האתרית HUN
- הוא מושפע מכעס

אטיולוגיה כללית

גורמים פתוגניים חיצוניים

רגשות

• כעס

• דאגה

• עצב

תזונה

איבוד דם

דפוסים מלאים

1. סטגנציה של צ'י הכבד
2. סטגנציה של צ'י הכבד ההופכת לחום
3. צ'י הכבד המרדני/ צ'י מורד של הכבד
4. סטזיס/ סטגנציה של דם הכבד
5. אש הכבד בוערת
6. חום לחות בכבד
7. קיפאון של קור בתעלת הכבד

דפוסים ריקים

1. חוסר דם הכבד
2. חוסר יין הכבד

דפוסים מלאים/ריקים

1. עליית יאנג הכבד
2. רוח פנימית של הכבד:
 - חום קיצוני המייצר רוח
 - עליית יאנג הכבד המייצרת רוח
 - אש הכבד מייצרת רוח
 - חוסר דם בכבד מייצר רוח

דפוסים משולבים

1. צ'י הכבד המרדני פולש לטחול
2. צ'י הכבד המרדני פולש לקיבה
3. אש הכבד פוגעת בריאות
4. חוסר דם בכבד ובלב
5. חוסר יין בכבד ובכליות

שתי הפונקציות החשובות ביותר של הכבד הן הבטחת זרימה חלקה של צ'י ואחסון דם.

הזרימה החלקה של צ'י הכבד משפיעה על כל האיברים ועל חלקים רבים ושונים בגוף. היא מסייעת לטחול להתמיר ולהעביר את תמצית המזון, ולקיבה לעכל ולהבשיל את המזון. צ'י הכבד גם מסייע לצ'י הטחול לעלות ולצ'י הקיבה לרדת. הוא מגרה את הפרשת המרה מכיס המרה ומבטיח זרימה חלקה של צ'י במעיים וברחם, ובכך משפיע על המחזור החודשי. בנוסף, הזרימה החלקה של צ'י הכבד משפיעה באופן מכריע על המצב הרגשי: הוא מבטיח "זרימה חלקה" של חיינו הרגשיים. אם צ'י הכבד מוגבל במשך תקופה ארוכה, חיינו הרגשיים יהיו מאופיינים בדיכאון, תסכול, עצבנות ומתח רגשי בכלל. מכיוון שהכבד מבטיח את הזרימה החלקה של הצ'י, אך אינו מעורב בייצור ובאספקה של הצ'י, הוא לעתים רחוקות סובל ממחסור בצ'י (אם כי הוא סובל ממחסור בדם וביין). בנוגע בהקשר של צ'י, הדפוס החשוב והנפוץ ביותר הוא קיפאון (תקיעות) של צ'י הכבד. עם זאת, מחסור בצ'י הכבד אכן קיים, והוא מתבטא בעיקר ברמה הפסיכולוגית בדיכאון, ביישנות וחוסר יוזמה. בעוד שצ'י הכבד לעיתים רחוקות נמצא בחסר, דם הכבד ויין הכבד לעתים קרובות נמצאים בחסר. הכבד מאחסן דם וזה יכול להתכלות בקלות, מה שמוביל לתסמינים של חוסר דם ווסת מועטה. דם הכבד יכול גם להיעשות סטגנטי: זה בדרך כלל תוצאה של סטגנציה של צ'י הכבד. צ'י הוא "מפקד הדם": כאשר הצ'י נעצר, הדם מתקשר. הקשר התפקודי בין הכבד לגידים מתבטא לעתים קרובות בנסיבות פתולוגיות בעיפות גופנית וחולשה או התכווצות הגידים. פתולוגיה של הכבד מאופיינת גם בשינויים מהירים כגון פריחות בעור המופיעות במהירות, טינטון פתאומי, התפרצויות זעם פתאומיות, או במקרים חמורים, התמוטטות פתאומית ותרדמת.

מאפיינים של פתולוגיות בכבד:

- שינויים מהירים (למשל במחלות עור)
- תנודות עליות וירידות (למשל ברמת האנרגיה, במצב הרוח)
- עליות וירידות רגשיות
- מצבי רוח, עצבנות
- בעיות עיניים
- תחושה של "נפיחות"
- בעיות גינקולוגיות

אתיולוגיה כללית :

גורמים פתוגניים חיצוניים -

שני הגורמים הפתוגניים המשפיעים על הכבד הם רוח ולחות.

רוח חיצונית אינה תוקפת את הכבד ישירות (היא פולשת לרמת הצ'י ההגנתי של הריאות), אך היא עלולה להחמיר מצב של רוח פנימית בכבד; היא עלולה, למשל, להאיץ התקפה של רוח בכבד, ולגרום לשבץ רוח. במקרים מסוימים, רוח חיצונית עלולה להחמיר את חוסר ההרמוניה הפנימית בכבד (כגון עליית יאנג בכבד), ולגרום לנוקשות בצוואר וכאבי ראש.

רוח חיצונית יכולה גם לעורר את הדם המאוחסן בכבד ולהתבטא בפריחות עוריות המופיעות בפתאומיות ומתפשטות במהירות, כמו במקרה של אורטיקריה.

במקרים כאלה, הרוח בדרך כלל משתלבת עם חום וגורמת לחום בדם הכבד ברמות השטחיות של תעלות חיבור הדם.

הופעה פתאומית ושינויים מהירים הם מאפיינים טיפוסיים של הרוח כגורם פתוגני.

רגשות:

כעס

כעס הינו הרגש המזוהה באופן הישיר ביותר לכבד.

כפי שהוזכר קודם (פרק 20, גורמים פנימיים למחלות), "כעס" הוא מונח רחב המשמש ברפואה הסינית, הכולל תחושות של תסכול, כעס מודחק, טינה וכעס. כמו תמיד ברפואה הסינית, הקשר בין רגש מסוים לאיבר הוא הדדי: תפקוד הכבד בהבטחת זרימה חלקה של צ'י משפיע עמוקות על המצב הרגשי, ולהפך, המצב הרגשי ישפיע על תפקוד הכבד.

לפיכך, אם הכבד מתפקד היטב והצ'י שלו זורם בצורה חלקה, המצב הרגשי יהיה שמח וחופשי והאדם יהיה במצב רוח טוב ויביע את רגשותיו בחופשיות.

אם הצ'י של הכבד עומד ולא זורם בחופשיות וללא הפרעה, הוא ייעצר וישפיע על המצב הרגשי, ויגרום לכעס ולעצבנות.

לאורך זמן, קיפאון של צ'י הכבד יפגע קשות בזרימת הצ'י ויגרום למצב רגשי קודר של טינה מתמדת,

כעס מודחק או דיכאון. ברמה הפיזית, רגשות מודחקים אלה עלולים "להישאר" בבית החזה, בבטן העליונה, בבטן או בגרון. האדם יחוש אז תחושת לחץ בחזה, או נפיחות בבטן התחתונה, או מתח באזור הבטן, או נפיחות בבטן או תחושת גוש בגרון עם קושי בבליעה. האדם יטה להיאנח לעתים קרובות.

אם צ'י הכבד מתמרד כלפי מעלה וגורם לעלייה של יאנג הכבד,

האדם יהיה עצבני מאוד, יאבד את שלוותו ויטבול מכאבי ראש.

קיפאון של צ'י לאורך זמן רב עלול להוביל לחום, שכן התפוצצות פנימית של צ'י הנגרמת על ידי אצירה רגשית מייצרת חום. מצב זה מתבטא לעתים קרובות בלשון עם צדדים וקצה אדומים, ואולי עם נקודות אדומות בקצה.

דאגה

דאגה משפיעה בעיקר על הריאות, אך היא יכולה להשפיע גם על הכבד ולגרום לקיפאון בצ'י הכבד. זה קורה במיוחד אם הדאגה קשורה לעבודה והיא מלווה בתסכול.

לפי ניסיון הכותב דאגה עלולה גם לגרום לעלייה ביאנג הכבד.

עצבות

למרות שבספרים סיניים הכבד תמיד ורק קשור לכעס, עצבות יכולה להשפיע גם על הכבד, וזה קורה במיוחד אצל נשים.

בפרק 8, "הציר הרוחני", נכתב: "עצבות הכבד וההלם פוגעים בנשמה האתרית".

באותו פרק נכתב גם: "כאשר העצבות משפיעה על הכבד, היא פוגעת בנשמה האתרית; זה גורם לבלבול נפשי... היין נפגע, הגידים מתכווצים ונוצרת אי-נוחות בהיפוכונדריה".

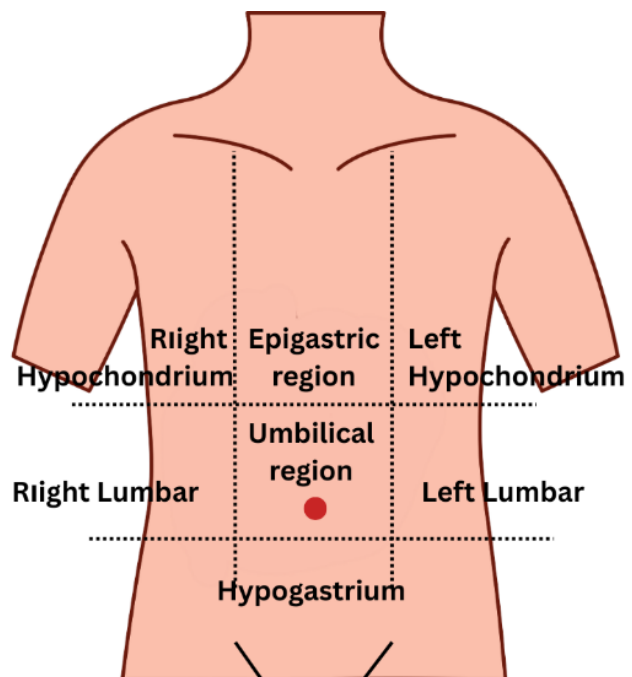
תזונה

צריכה מוגזמת של מזונות בעלי אנרגיה חמה (כגון בשר אדום, תבלינים ואלכוהול) עלולה להוביל ל"אש בכבד". צריכה מוגזמת של מזונות שומניים (כגון מוצרי חלב ומזונות מטוגנים) עלולה להוביל ללחות בכבד (ובדרך כלל גם בכיס המרה).

צריכה לא מספקת של מזונות מחממים ומזינים כגון בשר ודגנים, עלולה להוביל למצב של מחסור בדם, אשר עלול להוביל למחסור בדם הכבד. תופעה זו שכיחה יותר בקרב נשים, אשר זקוקות במיוחד לאספקה מספקת של מזונות המזינים את הדם בשלבים מסוימים בחייהן, כגון בגיל ההתבגרות ולאחר הלידה, וכן, במידה פחותה, לאחר כל מחזור.

איבוד דם

איבוד דם חמור, כגון איבוד דם לאחר לידה, עלול לגרום למחסור בדם הכבד.



דפוסים מלאים:

1. תקיעות צ'י הכבד - Liver-Qi stagnation

סימנים קליניים:

- תחושת נפיחות בהיפוכונדריה, בחזה, באפיגסטריום או בבטן, אנחות
- מלנכוליה, דיכאון, מצבי רוח, תנודות במצב הנפשי, תחושת מתח, תחושת גוש בגרון
- מחזור לא סדיר, נפיחות בשדיים לפני המחזור, מתח ורגזנות לפני המחזור
- **לשון:** צבע הגוף עשוי להיות רגיל, במקרים חמורים, היא עשויה להיות אדומה מעט בצדדים.

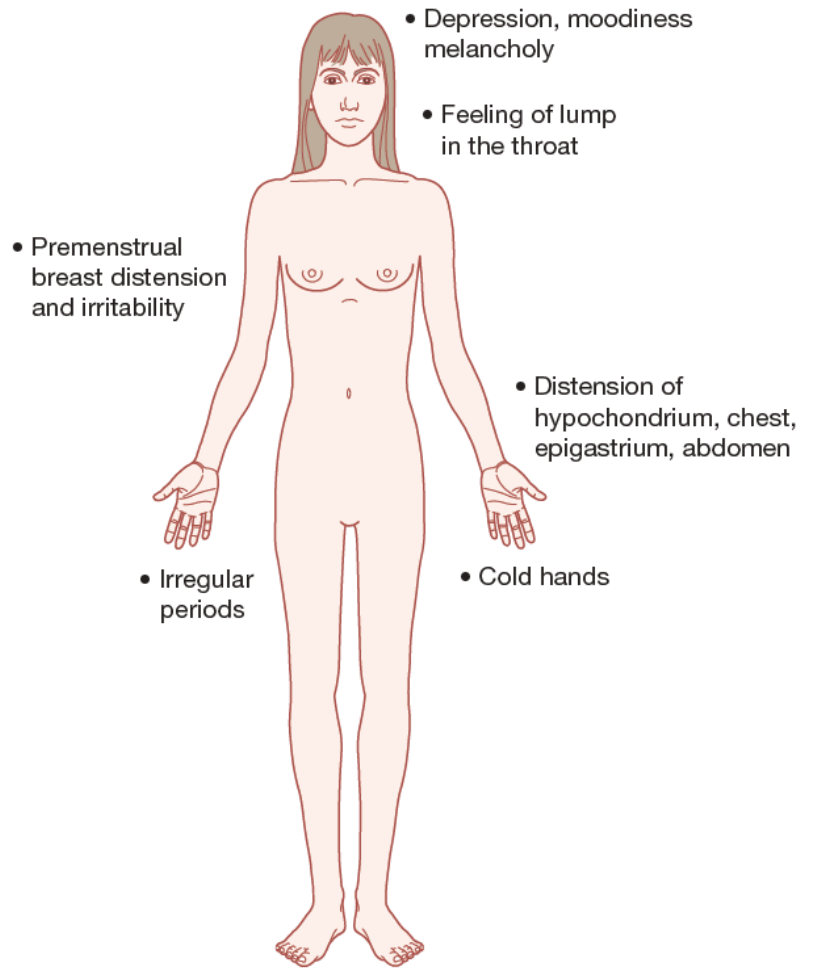
דופק: מיתרי, במיוחד בצד שמאל.

תסמינים עיקריים: תחושת נפיחות, דיכאון, מצבי רוח, דופק מתוח.

*תחושת מתיחות ודופק מתוח, הינם מספיקים לרוב לאבחנת תקיעות בצ'י הכבד

אטיולוגיה: מתח נפשי, בעיות בחיים הרגשיים הן ללא ספק הגורם החשוב ביותר (אם לא היחיד)

לקיפאון צ'י הכבד.



כפי שהוזכר קודם, מצב של תסכול, כעס מודחק או טינה לאורך זמן רב עלול לגרום להפרעה בזרימת הצ'י, כך שהצ'י לא יזרום בצורה חלקה וייתקע, מה שיגרום לקיפאון של צ'י הכבד.

== < זהו ללא ספק הדפוס הנפוץ ביותר בכבד וגם אחד הדפוסים הנפוצים ביותר באופן כללי (אם כי לדעת הכותב הוא נוטה להיות מאובחן יתר על המידה).

ברור שלא כל התופעות הנ"ל צריכות להיות נוכחות כדי להצדיק אבחנה של סטגנציה של צ'י הכבד.

ישנה חלוקה לשלוש קבוצות שונות כדי להדגיש את הפתולוגיה השונה של כל קבוצה.

קיפאון של צ'י הכבד הוא בעל השפעה רחבה מאוד ומתבטא במגוון רחב של תסמינים וסימנים.

ברמה הפיזית, קיפאון של צ'י הכבד יכול להתבטא בהיפוכונדריה, בחזה, באפיגסטריום ובבטן.

הקיפאון מתבטא בתחושת נפיחות אופיינית.

"נפיחות" היא תרגום של המילה הסינית zhang. נפיחות מתייחסת לתחושת נפיחות סובייקטיבית

של המטופל, אך באפיגסטריום ובבטן, היא יכולה גם להיראות וגם להיות מורגשת במישוש

באופן אובייקטיבי. בהתבוננות, הבטן אכן נראית נפוחה ובמישוש, היא מרגישה קשה במקצת אך אלסטית (כמו בלון). אנחה היא דרך ספונטנית לשחרר את הצ'י התקוע בחזה.

הקבוצה השנייה של תסמינים כוללת מספר ביטויים רגשיים, הנפוצים מאוד ואופייניים לקיפאון צ'י הכבד.

אלה נובעים מזרימה לקויה של צ'י ברמה הנפשית. קיפאון של צ'י הכבד מפריע ל"הגעה ועזיבה" של הנשמה האתרוית (הון) וגורם לדיכאון, תחושת חוסר תכלית, היעדר תוכניות, חלומות וכו'.

קיפאון הצ'י גורם גם לתחושת עצבנות.

הקיפאון של צ'י הכבד בגרון (שם עובר גם ערוץ הכבד) גורם לתחושה של גוש בגרון (ברפואה הסינית מתארים זאת כתחושה של "גרעין שזיף בגרון"). התחושה באה והולכת בהתאם למצב הרגשי. בדרך כלל, התסמינים הרגשיים משתנים.

האדם עובר תקופות של דיכאון, בהן מופיעים גם כל התסמינים הגופניים, ותקופות בהן הדיכאון נעלם והתסמינים הגופניים נעלמים.

תנודות אלו אופייניות לקיפאון צ'י הכבד.

לבסוף, קיפאון צ'י הכבד עלול לפגוע בתנועת הצ'י והדם בכלי הדם המכוונים והחודרים (רן מאי וצ'ונג מאי), ובכך להשפיע על הרחם, מה שמביא למחזור לא סדיר ולמתח קדם-וסתי עם נפיחות בשדיים (הנמצאים גם הם תחת השפעת הכבד).

דפוס זה הוא מסוג "מלא"/עודף ואין לטעות על ידי מצבו הרגשי של האדם, אשר עשוי להיראות "חסר" (כלומר, האדם מדוכא, רגיש ושקט). למרות מראהו, הוא נגרם על ידי "התפוצצות פנימית" של צ'י עקב קיפאון של צ'י הכבד וככזה, יש לטפל בו כדפוס "עודף".

במצבים כאלה, כאשר המטופל סובל מקיפאון צ'י הכבד אך נראה מאופק, הדופק המיתרי הוא תסמין חיוני המצביע על קיפאון צ'י הכבד.

חשוב לדון במראה הלשון בקיפאון צ'י הכבד. ברוב הספרים הסיניים נכתב שהלשון בקיפאון צ'י הכבד היא סגולה או בעלת צדדים סגולים. הכותב לא מסכים עם קביעה זו, ולדעתו שינוי בצבע גוף הלשון משקף שינוי במצב הדם יותר מאשר במצב הצ'י. לכן, אם הלשון סגולה, אני תמיד מייחס זאת לסטזיס דם.

במקרה של קיפאון צ'י, גוף הלשון עשוי למעשה לא לשנות את צבעו כלל, כך שהפתולוגיה הזו לא תופיע

על הלשון; במקרים חמורים של קיפאון צ'י, הלשון עשויה להיות מעט אדומה בצדדים.

איכות הדופק הקשורה לקיפאון צ'י היא נוקשה, ומדובר בממצא שכיח מאוד בפועל.

למעשה, אם הדופק אינו נוקשה (או לפחות נוקשה חלקית), אז לא מדובר בקיפאון צ'י הכבד.

יש לשים לב שבנשים, קיפאון צ'י הכבד עלול לפעמים להופיע כתוצאה ממחסור בדם הכבד או שהוא עשוי להיות קשור אליו. כאשר זה קורה, הדפוס הוא שילוב של עודף (קיפאון צ'י) וחוסר (דם הכבד).

התסמינים והסימנים יהיו שונים במקצת ובדרך כלל מהסוג החסר; מעל הכל, הדופק עשוי להיות בדרך כלל דק ורק מעט נוקשה בצד שמאל.

ישנם מעט תסמינים מוקדמים פתולוגיים של קיפאון צ'י הכבד מכיוון שדפוס זה עצמו הוא בדרך כלל השלב הראשוני

בתהליך פתולוגי הנובע מלחץ נפשי.

עם זאת, דפוס זה עלול להופיע כתוצאה משנית מחסר דם בכבד: הסיבה לכך היא שצ'י הכבד ודם הכבד הם היבטי היין והיאנג של הכבד, בהתאמה, והם משפיעים זה על זה.

מכיוון שהכליות הן "האם" של הכבד בתורת חמשת האלמנטים, מחסור בכליות עלול לגרום לקיפאון משני של צ'י הכבד.



התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

מכיוון שצ'י הוא "מפקד הדם" ו"כאשר הצ'י עומד במקום הדם מתקרח", קיפאון של צ'י הכבד לאורך זמן עלול בקלות לגרום לסטגנציה של דם הכבד. זו התוצאה החשובה ביותר של קיפאון צ'י הכבד, אשר תידון כדפוס נפרד. עם הזמן, קיפאון צ'י הכבד מוביל לעיתים קרובות ל חום בכבד.

עקרון הטיפול: להחליק את הכבד ולהניע את הצ'י.

שיטה: שיטת ניקוז, ללא מוקסה

נקודות:

- GB-34 מניעה את צ'י הכבד ומשפיעה במיוחד על אזור ההיפוכונדריה.
- LIV-3 גם מניעה את צ'י הכבד ומשפיעה במיוחד על הגרון והראש.
- LIV-13 מווסת את צ'י הכבד במבער האמצעי, במיוחד כאשר הוא פולש לטחול.
- LIV-14 מווסת את צ'י הכבד במבער האמצעי, במיוחד כאשר הוא משפיע על הקיבה.
- T.B.-6 מניעה את צ'י הכבד ומשפיעה במיוחד על צידי הגוף.
- P-6 מניעה את צ'י הכבד (בזכות הקשר בין תעלות הכבד והקרומ הלב בתוך הין הסופי). נקודה זו תהיה מתאימה במיוחד כאשר הקיפאון של צ'י הכבד נגרם על ידי בעיות רגשיות.

2. תקיעות בצ'י הכבד שהופכת לחום

Stagnant Liver-Qi turning into Heat

תסמינים קליניים:

נפיחות בהיפוכונדריה או באפיגסטריה, תחושת לחץ קלה בחזה, עצבנות, מלנכוליה, דיכאון, מצבי רוח, תחושת גוש בגרון, תחושת חום, פנים אדומות, צמא, נטייה להתפרצויות זעם, מתח קדם-וסתי, מחזור לא סדיר, נפיחות בשדיים לפני הווסת, מחזור כבד. לשון: אדומה בצדדים.

דופק: מיתרי במיוחד בצד שמאל, וקצת מהיר.

תסמינים עיקריים: תחושת נפיחות, עצבנות, תחושת חום, דופק חזק, צדדים אדומים של הלשון. טיפול: להוריד את החום, להפיג את העצבנות, להקל על תחושת הנפיחות.

אטיולוגיה:

מתח נפשי, האטיולוגיה של דפוס זה זהה לחלוטין לזו של קיפאון צ'י הכבד.

תזונה : צריכה מוגזמת של מזונות בעלי אנרגיה חמה (כגון בשר אדום, תבלינים ואלכוהול) עלולה להגביר התפתחות חום מקיפאון צ'י.

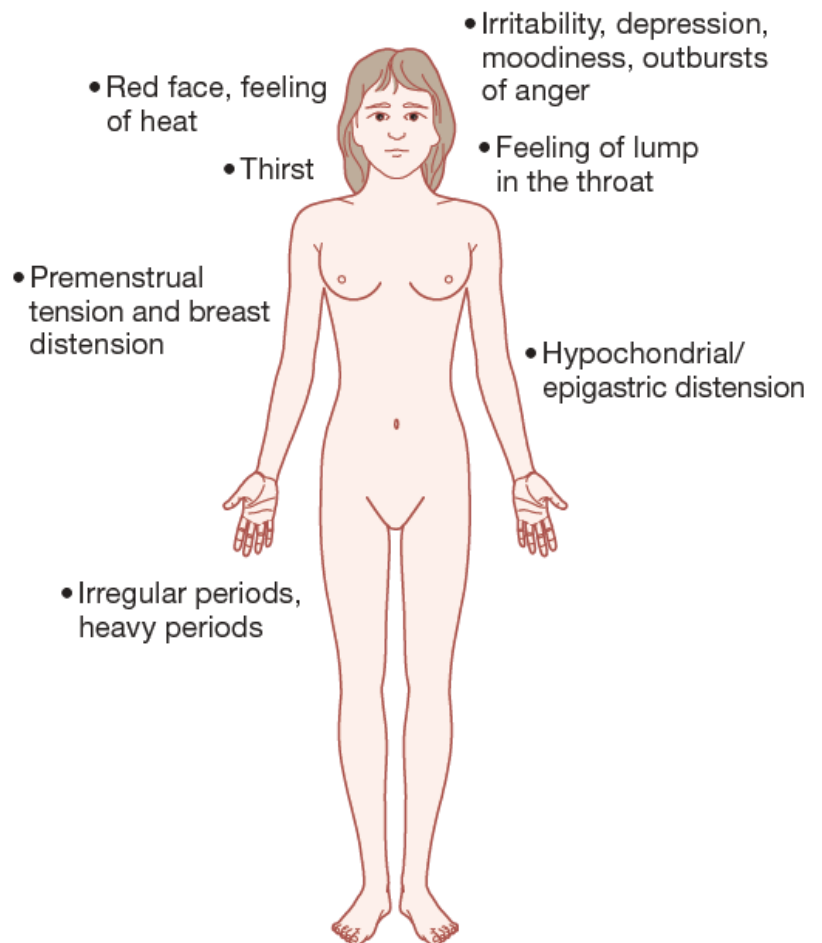


Figure 34.4 Liver-Qi stagnation turning into Heat

הפתולוגיה של קיפאון צ'י זהה לדפוס זה כמו לדפוס הקודם. בדפוס זה, יש חום הנובע מסטגנציה של צ'י המתבטא בתחושת חום, פנים אדומות, צמא, צדדים אדומים של הלשון ודופק מעט מהיר.

ברמה הרגשית, נוכחות החום גורמת לאדם להיות נוטה יותר להתפרצויות זעם ול חרדה, בעוד שסטגנציה של צ'י הכבד גורמת לאדם לדכא את הכעס יותר ולהיות מצוברח.

התסמין המוקדם הפתולוגי של דפוס זה הוא קיפאון צ'י הכבד.

דפוס זה נוטה להופיע כתוצאה מקיפאון צ'י כאשר הוא מופיע באופן עצמאי ולא כתוצאה מחסור בדם הכבד או מחסור בכליות.

התפתחויות פתולוגיות לדפוס זה:

החום שנוצר כתוצאה מהקיפאון של צ'י הכבד יכול, עם הזמן, להפוך לאש הכבד. בדפוס זה, החום הוא עוצמתי יותר

תקיעות צ'י הכבד = < חום בכבד = אש בכבד

עקרון הטיפול: להחליק את הכבד, להניע את הצ'י, לנקות קלות את החום.

שיטה: שיטת פיזור/ניקוז, ללא מוקסה.

נקודות:

נקודות: GB-34 Yanglingquan, LIV-3 Taichong, LIV-13

Zhangmen, LIV-14 Qimen, T.B.-6 Zhigou, P-6

Neiguan, LIV-2 Xingjian

הסבר הפעולות של שש הנקודות הראשונות כבר הוסברו בדפוס הקודם.

יש לשים לב שכאשר החום נובע מקיפאון צ'י, עקרון הטיפול העיקרי הוא להחליק את הכבד ולהניע את הצ'י, ולא

לנקות את החום באופן ישיר.

– LIV-2 בשימוש אם התסמינים והסימנים של חום בכבד בולטים.

Rebellious Liver-Qi צ'י מורד של הכבד

תסמינים קליניים:

נפיחות בהיפוכונדריה או באפיגסטריום, שיהוקים, אנחות, בחילות, הקאות, גיהוקים, "תחושת חוסר נוחות בקיבה", עצבנות; אצל נשים, נפיחות בשדיים.

לשון: במקרים קלים צבע הלשון עשוי שלא להשתנות; במקרים חמורים הצדדים יהיו אדומים.

דופק: מיתרי. הוא עשוי להיות חזק במיוחד במיקומים של הכבד והקיבה.

אטיולוגיה: לחץ נפשי, כעס, תסכול, דאגה וטינה עלולים לגרום למרד של צ'י הכבד.

תזונה: אכילה בחיפזון או במצב של לחץ, אכילה תוך כדי עבודה, כעס בזמן הארוחות ואכילה בעמידה עלולים לגרום למרד אופקי של צ'י הכבד.

בדפוס זה, צ'י הכבד "מורד" אופקית: כלומר, תנועתו האופקית באפיגסטריום (אשר בתנאים פיזיולוגיים מסייעת לתפקוד הקיבה והטחול) הופכת מוגזמת ופוגעת בירידת צ'י הקיבה.

יש לשים לב כי זהו מנגנון פתולוגי שונה מקיפאון צ'י.

בקיפאון צ'י, הזרימה החופשית של צ'י הכבד נפגעת וקיימים תסמינים רגשיים בולטים מאוד;

בצ'י כבד מרדני, התנועה האופקית של צ'י הכבד למעשה

מודגשת והתסמינים הרגשיים מועטים יותר. לעומת זאת, ישנם תסמינים רבים יותר במערכת העיכול

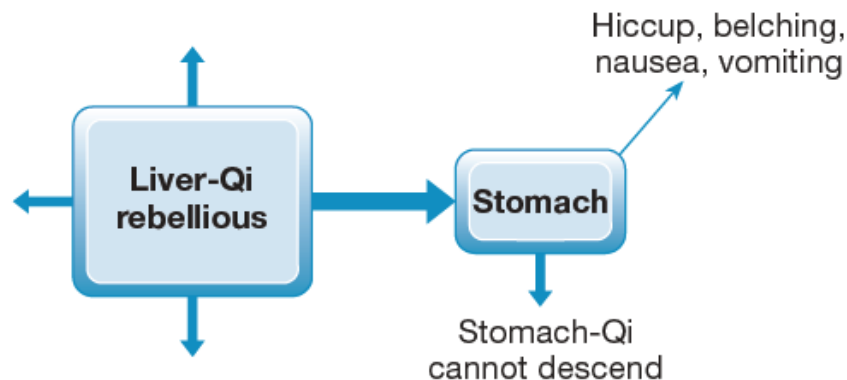


Figure 34.7 Rebellious Liver-Qi invading the Stomach

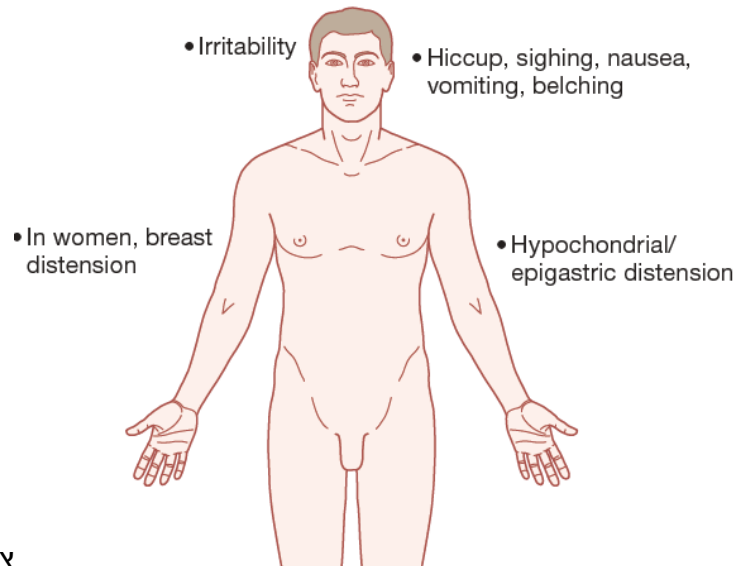
מלבד תחושת הנפיחות, רוב התסמינים בדפוס זה נובעים מהפגיעה בירידת צ'י הקיבה על ידי צ'י הכבד המורד.

תסמינים אלה הם: שיהוקים, גיהוקים, בחילות והקאות.

אצל נשים, עלולה להופיע נפיחות בשדיים עקב מרדנות צ'י הכבד כלפי מעלה בחזה, המשפיעה על השדיים.

דופק אופייני לדפוס זה הוא דופק

מיתרי בשתי עמדות האמצע (כלומר בעמדות הכבד והקיבה).



צ'י מורד

דפוס זה יכול להתפתח מהדפוס "תקיעות צ'י של הכבד" (אך לא להפך)

התפתחויות פתולוגיות לדפוס זה:

צ'י הכבד המרדני עלול בקלות לגרום לעליית יאנג הכבד, ובמקרה כזה, התסמינים מתבטאים בראש

(כאבי ראש, סחרחורות, טינטון)

עקרון הטיפול: להחליק את הכבד, להרגיע את צ'י הכבד.

שיטה: שיטת הפחתה, ללא מוקסה.

נקודות:

– **LIV-14** הוא הנקודה העיקרית לריסון צ'י הכבד כאשר הוא פולש לקיבה, כלומר הוא מביא להרמוניה

בין הכבד לקיבה.

– **P-6** מרגיע את צ'י הכבד המורד, גורם ל- צ'י הקיבה לרדת ומרגיע את הנפש.

– **G.B.-34** מחליק את הכבד ומניע את הצ'י. הוא פועל על ההיפוכונדריה.

– **LIV-3** מחליק את הכבד, מניע את הצ'י, מרגיע את הנפש ומרגיע את הנשמה האתרית.

– **T.B.-6** מניע את צ'י הכבד.

– **L.I.-4** מווסת את עלייתו וירידתו של הצ'י ולכן עוזר לדיכויו צ'י הכבד.

– **ST-21** ו-**ST-19** גורמים לצ'י הקיבה לרדת.

Liver-Blood stasis סטגנציית דם הכבד

תסמינים קליניים:

כאבים בהיפוכונדריה, כאבי בטן, הקאות דם, דימום מהאף, מחזור כואב, מחזור לא סדיר, דם וסת כהה וקרוש, עקרות, גושים בבטן, ציפורניים סגולות, שפתיים סגולות, עור סגול או כהה, עור יבש (במקרים חמורים), כתמים סגולים

לשון: סגולה במיוחד, או רק בצדדים. במקרים חמורים, יהיו כתמים סגולים בצדדים.

דופק: מיתרי או נוקשה.

תסמינים עיקריים: דם וסת כהה ומקריש, לשון סגולה.

אטיולוגיה

לסטזיס דם אין גורמים אטיולוגיים ישירים, שכן מדובר בפתולוגיה המתפתחת ממצבים פתולוגיים אחרים, בעיקר סטגנציה של צ'י, קור או חום.

הגורם השכיח ביותר לסטזיס דם בכבד הוא סטגנציה של צ'י הכבד,

ולכן הגורמים האטיולוגיים המובילים לסטגנציה של צ'י הכבד עלולים, בטווח הארוך, להוביל לסטזיס דם בכבד.

עקרון הטיפול: להחליק את הכבד, להניע את הצ'י, להניע את הדם, לסלק סטזיס

*כאב חד ולשון סגולה מספיקים כדי לאבחן סטזיס דם.

דפוס זה נובע לעיתים קרובות מהקיפאון של צ'י הכבד. כאשר הצ'י תקוע, בטווח הארוך הדבר מוביל לתקיעות של הדם.

הכבד אוגר את הדם והוא מושפע במיוחד מקיפאון של הדם.

כאשר דם הכבד תקוע, הדם בכלי הדם המכוונים והחודרים (Chong Mai ו-Ren) ייתקע גם הוא וישפיע על תפקוד המחזור החודשי.

הביטוי העיקרי של קיפאון הדם ברחם הוא דם מחזור כהה ומקריש ווסת כואבת.

קיפאון הדם מוביל לכאב, וכמו שהנפחות היא הסימפטום העיקרי של קיפאון הצ'י, כך הכאב הוא הסימפטום העיקרי של קיפאון הדם.

סטזיס דם גורם לעיתים קרובות לכאב חמור. סטזיס דם עלול להתרחש ללא כאב, אך כאב חד וחמור תמיד מעיד על סטזיס דם.

סטזיס של דם בכבד עלול לגרום לכאב לא רק במהלך (או לפני) המחזור, אלא גם באופן כללי בבטן בזמנים אחרים, והוא משפיע גם על גברים.

הכאב הנובע מהצטברות דם הוא בדרך כלל קבוע במקום אחד והוא בעל אופי דוקר/ חד.

זה יכול להיות מלווה גם בנפחות או בגוש בבטן שהוא קבוע. בעוד ש (קיפאון צ'י יכול להתבטא גם בגושים בבטן שבאים והולכים).

הקאות דם ודימום מהאף נגרמים על ידי סטזיס של דם בתעלת הכבד. הכבד בא לידי ביטוי בציפורניים, וצבען הסגול משקף את הסטזיס של הדם בכבד. סטזיס כללי של דם גורם גם לשפתיים ולעור סגולים.

במקרים חמורים, דם עומד חוסם את זרימת הנוזלים (עקב חילוף החומרים בין נוזלי הגוף והדם) והעור מתייבש. כתמים (בצבע סגול) נגרמים מדימום מתחת לעור במרידאני חיבור זעירים. הצבע הסגול של גוף הלשון משקף תקיעות של דם. במקרים חמורים יופיעו גם כתמים סגולים, בדרך כלל בצדדים. הדופק הקשה אופייני למצבי סטגנציית דם. *יכול להיות מצב של תקיעות דם בלא לשון סגולה. סטזיס דם הוא פתולוגיה חשובה מאוד בפועל, מכיוון שהוא עלול להוביל למחלות קשות; לעומת זאת, קיפאון צ'י כשלעצמו אינו יכול להוביל למחלות קשות. לדוגמת מחלת לב כלילית, שבץ מוחי וסרטן מאופיינים כולם בנוכחות סטזיס דם (בנוסף לדפוסים אחרים).

תסמינים מוקדמים פתולוגיים של דפוס זה:

• קיפאון צ'י

• קור

• חום

• מחסור בצ'י

• מחסור בדם

• ליחה

שלושת הדפוסים הראשונים הם הסימנים המקדימים הנפוצים ביותר לסטזיס בכבד ובדם. קיפאון צ'י הוא כנראה הסימן המקדים הנפוץ ביותר לסטזיס בדם. צ'י הוא המפקד של הדם: כאשר הצ'י זז, הדם זז. לעומת זאת, כאשר הצ'י נתקע, הדם נתקע. קור מוביל לעיתים קרובות לסטזיס דם מכיוון שהוא מקריש את הדם. קור הוא גורם שכיח לסטזיס דם ברחם. דם דחוס יוביל לסטגנציית דם בלב. חוסר צ'י עלול לגרום לסטזיס דם מכיוון שהצ'י החסר לא מצליח להניע את הדם. אצל נשים, השילוב של מחסור בדם וסטזיס דם הוא יחסית נפוץ: הוא יתבטא, למשל, במחזור מועט אך כואב. לבסוף, ליחה מקיימת אינטראקציה עם סטזיס דם והן מחמירות זו את זו. זה קורה בשל הקשר ההדדי בין דם ונוזלי גוף. ליחה היא הצטברות פתולוגית של נוזלי גוף: בהתחשב בקשר ההדדי בין נוזלי גוף ודם, הצטברות פתולוגית זו עלולה להחמיר סטזיס דם. האינטראקציה בין ליחה וסטזיס דם שכיחה יותר בקרב קשישים והיא מזיקה במיוחד מכיוון שהיא קיימת במחלות מודרניות חמורות כגון מחלת לב כלילית, שבץ וסרטן. התפתחויות פתולוגיות מהדפוס: קיפאון בכבד ובדם לאורך זמן עלול לגרום ליובש.

זה קורה בגלל חילוף החומרים בין הדם לנוזלי הגוף, כך שכאשר הדם נתקע, הוא פוגע בייצור נוזלי הגוף ומוביל ליובש.

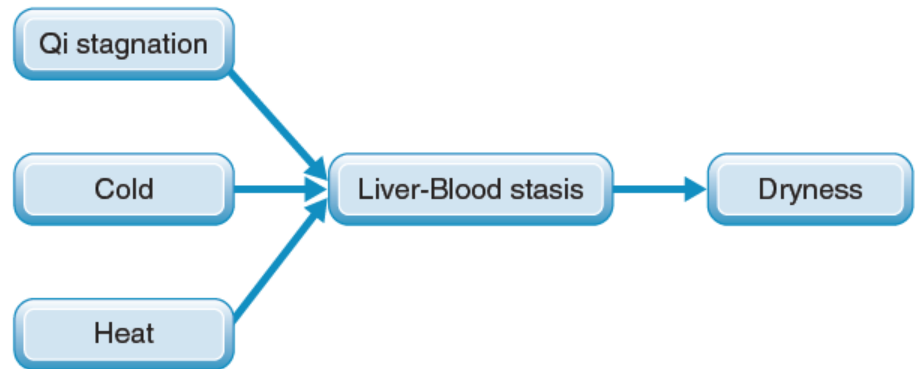


Figure 34.10 Liver-Blood stasis pattern: precursors and developments

עקרון הטיפול: להחליק את הכבד, להניע את הצ'י, להניע את הדם, לסלק סטזיס. טכניקת פיזור, ללא מוקסה.

נקודות:

- **GB-34** מזיז את צ'י הכבד; על מנת להניע את הדם, יש צורך להניע את הצ'י.
- **LIV-3** מזיז את צ'י הכבד והדם.
- **BL-18** מזיז את דם הכבד.
- **BL-17** הוא נקודת האיסוף (Hui) של הדם, והוא יכול להניע את הדם (כאשר משתמשים בו עם מחט בלבד, ללא מוקסה).
- **SP-10** מניע את הדם.
- **Sp 10 + bl17** משמשות לעתים קרובות בשילוב כדי להניע את הדם, בהתאמה, במבער העליון והתחתון.
- **Ren-6** מזיז את הצ'י (מלבד חיזוק הצ'י) ומשמש להזזת הצ'י והדם בבטן, במקרים של כאבי בטן.
- **SP-4 Gongsun** ו-**P-6 Neiguan** פותחים את הערוץ המיוחד (Chong Mai). כלי מיוחד זה הוא ים הדם והשימוש העיקרי בו הוא הזזת הדם במקרים של סטזיס דם.
- **ST-29** מזיז את הדם במבער התחתון וברחם.
- **KI-14** הוא נקודה בכלי החדיר המזיזת את הדם.
- **LIV-5** ו-**LIV-6** מזיזים את צ'י הכבד ואת דם הכבד.

Liver-Fire blazing - אש הכבד בוערת

תסמינים קליניים:

עצבנות, נטייה להתפרצויות זעם, טינטון, חירשות, כאבי ראש זמניים, סחרחורת, אדמומיות בפנים ובעיניים, צמא, טעם מר, שינה מופרעת, עצירות עם צואה יבשה, שתן צהוב כהה, דימום מהאף, הקאת דם, שיעול דם לשון: גוף אדום, אדום יותר בצדדים, ציפוי צהוב יבש.

דופק: מלא-מתוח-מהיר.

תסמינים עיקריים: כאב ראש, עצבנות, פנים אדומות, עיניים אדומות, לשון אדומה עם ציפוי צהוב.

אש:

1. **אש מייבשת נוזלים (צמא, שתן כהה, צואה יבשה)**

2. **אש מסעירה את הנפש (תסיסה, נדודי שינה, חוסר מנוחה)**

3. **אש עלולה לגרום לדימום (דימום וסת, דימום מהאף)**

אטיולוגיה:

הגורם השכיח ביותר לדפוס זה הוא מצב נפשי מתמשך של כעס, טינה, כעס מודחק או תסכול. הדיכוי הרגשי גורם לתקיעות של הצי, מה שמביא לעלייה בחום ו"התפוצצות". תזונה: צריכה מוגזמת של אלכוהול, מזונות מטוגנים ובשר אדום עלולה לתרום להיווצרות חום בכבד.

פתולוגיה:

דפוס זה מאופיין בחום מלא בכבד.

אש הכבד נוטה באופן טבעי להתפרץ כלפי מעלה; לכן, רבים מהתסמינים והסימנים משקפים את עליית אש הכבד לכיוון הראש, כגון פנים ועיניים אדומות, כאב ראש זמני, סחרחורת, שינה מופרעת על ידי חלומות ורגישות יתר. האש מסעירה את הנפש, והסימפטומים הנפשיים-רגשיים יהיו בולטים יותר מאלה של עליית יאנג הכבד או סטגנציה של צי הכבד. המטופל יהיה נוטה יותר להתפרצויות זעם.

אש הכבד עולה לאוזניים ומערפלת את פתחי האוזניים, גורמת לטינטון ולחירשות, אשר במקרה זה יתאפיינו בהופעה פתאומית. הטינטון יתבטא כצפצוף גבוה.

הכאב הראש נגרם מעליית היאנג והאש של הכבד, והוא יהיה עז מאוד, פועם באופיו, בדרך כלל ברקה או בעין. הטעם המר נגרם מעליית אש הכבד לגרון ולפה. טעם מר יכול להיגרם גם על ידי אש הלב, ובמקרה זה הוא מופיע רק

בבוקר לאחר שינה גרועה (הוא לא יופיע לאחר שינה טובה).

אם הטעם המר נגרם על ידי אש הכבד, הוא יופיע לאורך כל היום ולא רק בבוקר.

אש הכבד מייבשת את נוזלי הגוף, מה שמוביל לעצירות עם צואה יבשה ושתן מרוכז וכהה.

במקרים ספורים, אש הכבד מחממת את הדם וגורמת לו לזלוג, מה שמביא לדמם מהאף, הקאות או שיעול דמי.

הגוף האדום של הלשון משקף את החום, והצבע האדום יותר בצידו הלשון משקף את מיקום החום בכבד. הציפוי הצהוב והיבש מאשר שמדובר בחום מלא.

הדופק המהיר והמלא משקף חום מלא, והדופק המיתרי משקף את מיקום החום בכבד.

תסמינים מוקדמים פתולוגיים של דפוס זה:

אש הכבד נובעת לעיתים קרובות עקב מצב ממושך של תקיעות בצ'י הכבד.

: כאשר הצ'י הכבד תקוע במשך זמן רב, הוא "מתפוצץ" וגורם לחום, אשר יכולה להפוך לאש.

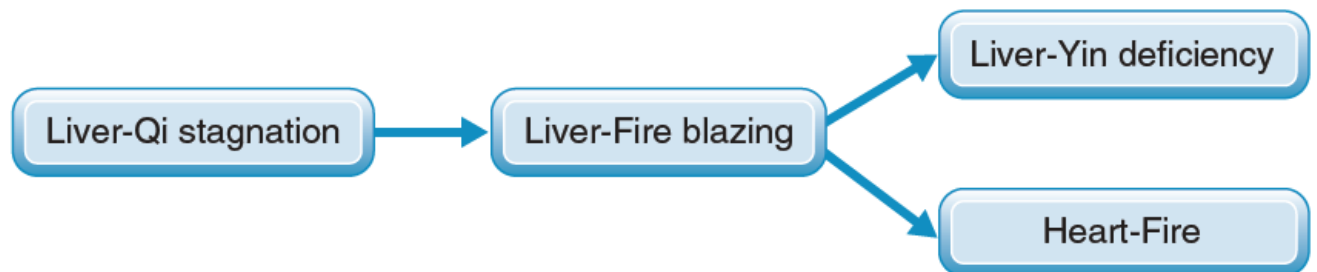
עליית יאנג הכבד יכולה גם להפוך לאש הכבד, במיוחד כאשר ישנם גורמים אטיולוגיים תזונתיים.

לדוגמה, יאנג הכבד יכול להפוך לאש הכבד כאשר יש חוסר איזון בין יאנג ויין.

התפתחויות פתולוגיות מדפוס:

אש הכבד עלולה לייבש את היין ולכן עלולה לגרום למחסור ביין הכבד. אש הכבד מועברת בקלות

ללב, וגורמת לאש משגשגת בלב: סביר להניח שיקרה כאשר לחץ נפשי חמור הוא הגורם לבעיה.



עיקרון טיפול:

לנקות את הכבד, לנקז את האש

שיטה: שיטת הפחתה, ללא מוקסה.

נקודות:

– **LIV-2** הוא הנקודה העיקרית לשימוש: היא ספציפית לניקוז אש הכבד.

– **LIV-3** מנקזת את הכבד.

– **GB-20** מנקזת את אש הכבד ומרגיעה את עליית צ'י הכבד. נקודה חשובה מאוד לשימוש במקרה של בעיות עיניים או כאבי ראש הנגרמים מאש הכבד.

– **Taiyang** (נק' אקסטרה) מנקה את אש הכבד ומשמשת לטיפול בכאבי ראש טמפורליים.

– **GB-13** מדכא את עליית יאנג הכבד ומרגיע את הנפש.

– **L.I.-11** מנקה חום.

– **G.B.-1, G.B.-9, G.B.-8** ו-**G.B.-6** הן נקודות מקומיות חשובות, נקודות מקומיות חשובות עבור אש הכבד העולה לראש, יש להשתמש בהן רק אם יש כאבי ראש.

– **SP-6** משמש להזנת היין, מה שיעזור לניקוז האש.

– **LIV-1** מנקה את הכבד ומרגיע את עליית יאנג הכבד ואש הכבד.

Damp-Heat in the Liver חום ולחות בכבד

תסמינים קליניים:

תחושת מלאות באזור ההיפוכונדריה, הבטן או ההיפוגסטריום,

טעם מר, טעם דביק, תיאבון ירוד, בחילה, תחושת כבדות בגוף, הפרשות נרתיקיות צהובות, גרד בנרתיק, אקזמה או פצעים בפות, דימום ו/או כאבים באמצע המחזור, כאבים, אדמומיות ונפיחות באשך, פריחות בעור איברי המין, חטטים (נגע עור עורי מוצק ומורם קטן) או שלפוחיות וגרד, קשיים במתן שתן, צריבה במתן שתן, שתן כהה.

לשון: גוף אדום עם צדדים אדומים יותר, ציפוי צהוב דביק.

דופק: חלקלק-מיתרי-מהיר.

תסמינים עיקריים: מלאות בהיפוכונדריה ובבטן, תחושת כבדות, בחילה, טעם מר ודביק, ציפוי צהוב דביק, דופק חלקלק.

אתיולוגיה:

תזונה: צריכה מוגזמת של מוצרי חלב ומזונות שומניים או תזונה לא סדירה מובילה להיווצרות לחות.

גורמים פתוגניים חיצוניים:

לחות חיצונית היא גורם שכיח להיווצרות לחות-חום. הלחות החיצונית פולשת לתעלות הרגליים (במקרה זה הכבד) ואז יכולה להתיישב בקלות באיברים. עם הזמן, הלחות משתלבת לעתים קרובות עם החום ויוצרת לחות-חום. במדינות טרופיות חמות, הלחות החיצונית והחום פולשים לגוף וגורמים ללחות-חום.

פתולוגיה:

דפוס זה נובע משילוב של חום בכבד ולחות. תחושת מלאות אופיינית ללחות. לחות היא "דביקה" וגורמת לטעם דביק, להפרשות נרתיקיות ולפצעים בנרתיק.

לחות מחלחלת כלפי מטה, ומסיבה זו הוא מתבטא לעתים קרובות באברי המין עם פצעים או אקזמה באזור זה. לחות חוסמת את המבער האמצעי, ופוגעת בירידת צ'י הקיבה: זה גורם לבחילות ולחוסר תיאבון. לחות היא 'כבדה' והיא גורמת לתחושת כבדות אופיינית בגוף.

לחות מחלחלת כלפי מטה ועשויה לחסום את דרכי השתן, גורמת לצריבה במתן שתן ולקושי במתן שתן. הדביקות של ציפוי הלשון מעידה על נוכחות של לחות, וגם הדופק החלקלק משקף לחות. הדופק עשוי להיות גם מיתרי, מה שמשקף חוסר הרמוניה בכבד.

תסמינים מקדימים פתולוגיים של הדפוס:

חוסר ב-Qi של הטחול עשוי להיות תסמין מקדים לדפוס זה,

מכיוון שלחות עלולה להיווצר כאשר הטחול אינו ממלא את תפקידו בתחום ההובלה והתמרה.

קיפאון ממושך של צ'י הכבד עלול להוביל לחום בכבד, המשתלב עם הלחות. כל אחד מהגורמים לקיפאון צ'י הכבד (כעס יתר וכו') עלול, אם כן, לתרום לדפוס זה.

התפתחויות פתולוגיות: לחות עלולה להוביל להיווצרות ליחה כאשר היא נמשכת מספר שנים

עקרון הטיפול: הסרת לחות, ניקוי הכבד, ניקוי חום.

שיטה: שיטת הפחתה בכל הנקודות למעט Ren-12, שיש לחזק אותה.

נקודות:

- **LIV-14** מווסת את צ'י הכבד בהיפוכונדריה ובאפיגסטריום.
- **GB-34** מפיג לחות בכבד ובכיס המרה.
- **BL-18** מפיג לחות מהכבד.
- **Ren-12** מחזק את הטחול כדי לפתור
- **Ren-12** מחזק את הטחול כדי לפתור את הלחות.
- **SP-9** ו-**SP-6** פותרים את הלחות. בפרט,
- **SP-9** ו-**SP-6** פותרים את הלחות מהמבער התחתון.
- **LI-11** פותר את הלחות ומנקה את החום.
- **LIV-2** מנקה את חום הכבד.

Stagnation of Cold in the Liver channel

סטגנציית קור בערוץ הכבד

תסמינים קליניים:

תחושת מלאות ונפיחות בבטן התחתונה עם כאב המקרין כלפי מטה לאשכים ולשק האשכים וכלפי מעלה לבית החזה, הכאב מוקל על ידי חום, מתיחה של האשכים או התכווצות של שק האשכים, כאב ראש אוקסיפיטלי, תחושת קור, ידיים ורגליים קרות, הקאות של נוזל צלול או הקאות יבשות.. בנשים עלול להופיע הצטמקות של הנרתיק.

לשון: חיוורת ולחה עם ציפוי לבן.

דופק: עמוק, מתוח ואיטי.

תסמינים עיקריים: כאב בבטן התחתונה המוקרן לשק האשכים, ידיים ורגליים קרות, דופק מיתרי, עמוק ואיטי.

דפוס זה נובע מפלישת קור חיצוני.

פתולוגיה זו נגרמת על ידי פלישה של קור לתעלת הכבד.

תעלת הכבד זורמת סביב איברי המין החיצוניים, הקור מכווץ, ומכאן הכאב וההתכווצות של האשך.

הדופק עמוק, מה שמשקף את נוכחותו של קור פנימי, מיתרי שמשקף את השפעת הכבד, ואיטי, מה שמשקף את נוכחותו של קור.

תסמינים מוקדמים של דפוס זה:

מצב פנימי קיים של סטגנציה של צ'י הכבד עלול להגביר את הנטייה של המטופל לפתח דפוס זה לאחר פלישת קור.

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

קיפאון של קור בתעלת הכבד עלול להוביל לקיפאון של צ'י הכבד במבער התחתון

עקרון הטיפול: לנקות את הכבד, לגרש את הקור.

שיטה: שיטת הפחתה, ניתן להשתמש במוקסה:

נקודות:

– **Ren-3** עם מוקסה מפזר קור מהמבער התחתון.

– **LIV-5**, נקודת החיבור של תעלת הכבד המתחברת, הזורמת סביב איברי המין, יכולה לפזר קור מתעלת הכבד.

– **LIV-1** מנקה את תעלת הכבד ומסיר את החסימה של הקור מהמבער התחתון.

– **LIV-3** פותר עוויתות ומסייע להקל על התכווצויות.

דפוסים ריקים:

1

Liver-Blood deficiency חסר בדם הכבד

תסמינים קליניים:

סחרחורת, חוסר תחושה או עקצוץ בגפיים, נדודי שינה, ראייה מטושטשת, "מרחפים" בעיניים, ירידה בראייה, בלילה,

וסת מועטה או אמנוריאה, עור חיוור וחסר ברק, שפתיים חיוורות, חולשת שרירים, התכווצויות, ציפורניים יבשות ושברות, שיער ועור יבשים, דיכאון, תחושה של חוסר תכלית.

לשון: גוף חיוור, במיוחד בצדדים, אשר במקרים קיצוניים יכול לקבל צבע כתמתם, דקה וקצת יבשה.

דופק: מחוספס או דק

תסמינים עיקריים: ראייה מטושטשת, מחזור מועט, עור חיוור ודהוי, לשון חיוורת.

אטיולוגיה:

תזונה: תזונה דלה במזון או חסרת מזונות המסייעים לייצור דם (כגון בשר ודגנים) עלולה להחליש את הטחול, אשר בתורו אינו יכול לייצר מספיק דם. כאשר הטחול אינו מייצר מספיק דם, הכבד אינו מאחסן מספיק דם.

מתח נפשי:

רגשות כגון עצב וצער עלולים לדלדל את דם הכבד באופן ישיר, כפי שצוין לעיל תחת "אטיולוגיה כללית". מתח נפשי עלול גם הוא להוביל לחוסר בדם, תחילה על ידי דלדול הצ', אשר לאחר מכן אינו מצליח לייצר מספיק דם.

פעילות גופנית מוגזמת:

פעילות גופנית מוגזמת פוגעת בעיקר ביאנג של הטחול והכליות. ככל שהטחול והכליות נחלשים, הם עלולים לגרום לחוסר דם, שכן צ'י המזון של הטחול הוא המקור לדם, והכליות הן המקור לטיאן גוי, המייצר דם וסת. זו הסיבה לכך שנשים ספורטאיות לעתים קרובות מפתחות אמנוריאה. עם זאת, פעילות גופנית מוגזמת פוגעת גם בגידים ולכן בכבד: בטווח הארוך, הדבר עלול להוביל למחסור בדם הכבד.

איבוד דם:

דימום חמור (כגון במהלך לידה) עלול לגרום גם למחסור בדם הכבד.

פתולוגיה:

חוסר בדם הכבד שכיח הרבה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. הכבד אוגר דם וכל חוסר בדם מתבטא לעתים קרובות בתחום הכבד.

מכיוון שהכבד נפתח לעיניים, כאשר יש חוסר בדם הכבד העיניים יחסרו הזנה ולחות, כך שהן לא יוכלו לראות בבהירות.

הכבד שולט על הגידים, וכאשר יש מחסור בדם הכבד, הם יחסרו הזנה ולחלוח והאדם יסבול מחולשת שרירים, התכווצויות או עקצוץ.

סחרחורת, שפתיים חיוורות, עור חיוור ודהוי הם כולם סימנים למחסור כללי בדם. מכיוון שהכבד בא לידי ביטוי בציפורניים, כאשר יש מחסור בדם בכבד, הן מאבדות את הזנתן והופכות יבשות ושברות.

דם הכבד קשור קשר הדוק לכלי הדם המכוונים והחודרים (Chong Mai ו-Ren Mai), אשר תלויים בכבד לאספקת הדם שלהם. לפיכך, כאשר יש מחסור בדם הכבד, גם כלי הדם המכוונים והחודרים יסבלו ממחסור בדם, מה שיגרום למחזור מועט או להיעדר מחזור כלל.

הכבד מאכלס את הנשמה האתרית (הון) והדם של הכבד בפרט "מעגן" את הנשמה האתרית בלילה. כאשר דם הכבד חסר, הוא עלול שלא לעגן את הנשמה האתרית בלילה והחולה לא יכול לישון היטב או שיהיו לו חלומות רבים.

הנשמה האתרית אחראית על 'הבוא והלך' של התודעה ואחראית על היכולת לתכנן, להציב מטרות, להקריין על אחרים, חלומות בחיים וכו'. כאשר דם הכבד חסר, הנשמה האתרית אינה מושרשת בדם הכבד, דבר שעלול להביא ל"בוא והלך" מוגזם שלה: זה גורם לנדודי שינה, חרדה ונטייה לריבוי פרויקטים, מטרות, חלומות ותוכניות באופן "מפוזר" למדי. לעומת זאת, כאשר גם דם הכבד וגם צ'י הכבד חסרים, אין מספיק "בוא והלך" של הנשמה האתרית, והאדם עלול להפוך לדיכאוני ולחוש חסר תכלית.

הכבד והדם מזינים:

- עיניים: ראייה מטושטשת
- גידים: עקצוץ, התכווצויות
- ציפורניים: ציפורניים מחורצות
- רחם: מחזור מועט
- נשמה אתרית: נדודי שינה, חלומות

הלשון חיוורת והיובש הקל בה מעיד על חוסר בדם. במקרים חמורים, הלשון תהיה גם דקה. ראוי לציין כאן כי למרות שחוסר בדם נוטה לגרום ללשון להיות דקה, בפועל, לשון דקה אינה נראית לעתים קרובות ולשון נפוחה היא נפוצה הרבה יותר. הסיבה לכך היא לחות וליחה (הגורמות לנפיחות הלשון) הן גורמים פתוגניים נפוצים ורווחים: לכן, למרות שהחולה עשוי לסבול ממחסור בדם, נפיחות הלשון "מסווה" זאת. דופק מקוטע/ מחוספס או עדין אופייני למחסור בדם.

דפוסים מקדימים לחסר דם הכבד:

הכליות ממלאות תפקיד ביצירת הדם, וחוסר בכליות עלול להוביל לחוסר בדם.

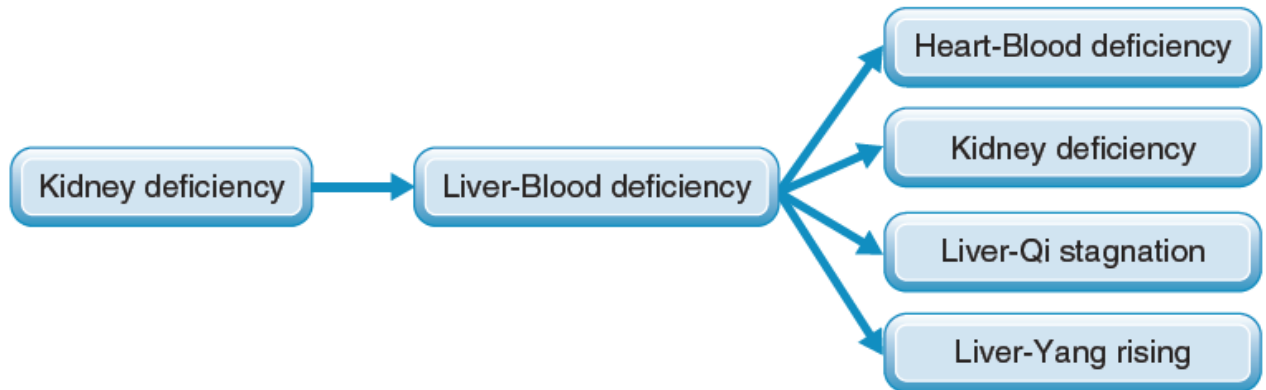
התפתחויות פתולוגיות מהדפוס

חוסר בדם הכבד מוביל לעיתים קרובות לחוסר בדם הלב, במיוחד כאשר המטופל נתון ללחץ רגשי.

מכיוון שהדם ממלא תפקיד ביצירת התמצית והכבד והכליות חולקים קשר פיזיולוגי הדוק מאוד, חוסר בדם הכבד עלול להוביל לחוסר בכליות (או להיפך).

אצל נשים, חוסר בדם הכבד מוביל לעיתים קרובות לקיפאון משני של צ'י הכבד, ובמקרה זה התסמינים של קיפאון הצ'י מתונים יותר, יש דיכאון קדם-וסתי ולא עצבנות, והדופק רק מעט מיתרי ודק.

אצל נשים, מחסור בדם הכבד הוא הגורם השכיח ביותר לעליית יאנג הכבד, המובילים לכאבי ראש. בדרך כלל, האישה תסבול משני סוגים של כאבי ראש: כאב עמום הנובע מחוסר בדם בכבד והתקפים מזדמנים של כאב ראש חמור ופועם הנובע מעליית יאנג בכבד.



- השלכות של מחסור בכבד-דם
1. עלול להוביל למחסור בלב-דם
 2. עלול להוביל למחסור בכליות
 3. עלול להוביל לקיפאון משני של צ'י הכבד
 4. עלול להוביל לעלייה ביאנג הכבד

עקרון הטיפול: חיזוק הכבד, הזנת הדם.

שיטה: חיזוק, ניתן להשתמש במוקסה.

נקודות:

– **LIV-8** מזינה את דם הכבד.

– **ST-36** ו-**SP-6** מחזקים את הצ'י שלאחר הלידה כדי לייצר דם. השילוב של שלושת הנקודות הללו, **LIV-8, ST-36** ו-**SP-6**, מצוין להזנת הדם.

– **Ren-4** (עם מוקסה ישירה) מזין את הדם ובמיוחד את דם הווסת.

– **BL-18** מחזק את הכבד.

– **BL-20** מחזק את הטחול לייצור דם.

– **BL-23** מחזק את הכליות לייצור דם.

– **BL-17** עם מוקסה ישירה, מזין את הדם.

– **Yuyao** הוא נקודה מקומית טובה לכאבי ראש קלים או ראייה מטושטשת כתוצאה מחוסר דם בכבד.

2

Liver-Yin deficiency

חולשת יין הכבד

תסמינים קליניים:

סחרחורת, חוסר תחושה או עקצוץ בגפיים, נדודי שינה, ראייה מטושטשת, "זבובים" בעיניים, יובש בעיניים, ירידה בראיית לילה, וסת מועט או אמנוריה, עור חיוור וחוסר ברק עם עצמות לחיים אדומות, חולשת שרירים, התכווצויות, ציפורניים יבשות ושבריות, שיער ועור יבשים מאוד, דיכאון, תחושת חוסר תכלית.

לשון: צבע רגיל ללא ציפוי או עם ציפוי ללא שורש

דופק: צף-ריק.

תסמינים עיקריים: ראייה מטושטשת, יובש בעיניים, לשון ללא ציפוי.

חום ריק:

סומק בלחיים, חרדה, תחושת חום בערב, הזעת לילה, חום בכפות הידיים, צמא עם רצון לשתות בלגימות קטנות, דימום וסת כבד.

לשון: אדומה ללא ציפוי.

דופק: צף-ריק וקצת מהיר.

האטיולוגיה של חוסר יין בכבד זהה לחלוטין לאטיולוגיה של חוסר דם בכבד.

פתולוגיה:

חוסר יין בכבד קשור קשר הדוק לחוסר דם בכבד.

כפי שניתן לראות מרשימת התופעות הקליניות, חוסר יין בכבד כולל את כל אותם תסמינים וסימנים כמו חוסר דם בכבד.

התופעות הקליניות העיקריות המבדילות בין חוסר יין בכבד לחוסר דם בכבד הן יובש בעיניים, עצמות לחיים אדומות ולשון ללא ציפוי.

יובש בעיניים נגרם מחוסר יין בכבד שאינו מזין ומלחלח את העיניים. עצמות לחיים אדומות נגרמות מחום ריק הנובע מחוסר יין, אף על פי שהלחיים עשויות להיות חיוורות מחוסר דם בכבד.

היעדר ציפוי על הלשון הוא סימן חשוב המבדיל דפוס זה. יש לשים לב כי הלשון לא בהכרח תהיה אדומה, שכן היא הופכת לכזו רק כאשר החום הריק הוא דומיננטי.

כאשר מחסור ביין מתפתח, מתפתח חום ריק וזה גורם ללחיים להיות אדומות יותר, צמא עם רצון לשתות בלגימות קטנות, הזעת לילה וחום בכפות הידיים.

חום ריק משפיע גם על המטופל מנקודת מבט נפשית-רגשית. כאשר יש מחסור ביין בכבד וחום ריק, הדבר מסעיר את הנשמה האתרית (שחסרה שורשים מכיוון שיש מחסור ביין בכבד) כך שהיא "באה והולכת" יותר מדי, וגורמת לחרדה, נדודי שינה, חוסר מנוחה נפשית ופעילות נפשית מוגזמת במונחים של תוכניות, פרויקטים, חלומות ומטרות, אשר נרדפים בצורה "מפוזרת" למדי.

תסמינים מוקדמים פתולוגיים של דפוס זה:

חוסר בדם הכבד הוא כמעט תמיד התסמין המוקדם של חוסר ביין הכבד. חוסר ביין הכליות גם מאפשר התפתחות חוסר ביין הכבד מחוסר בדם הכבד.

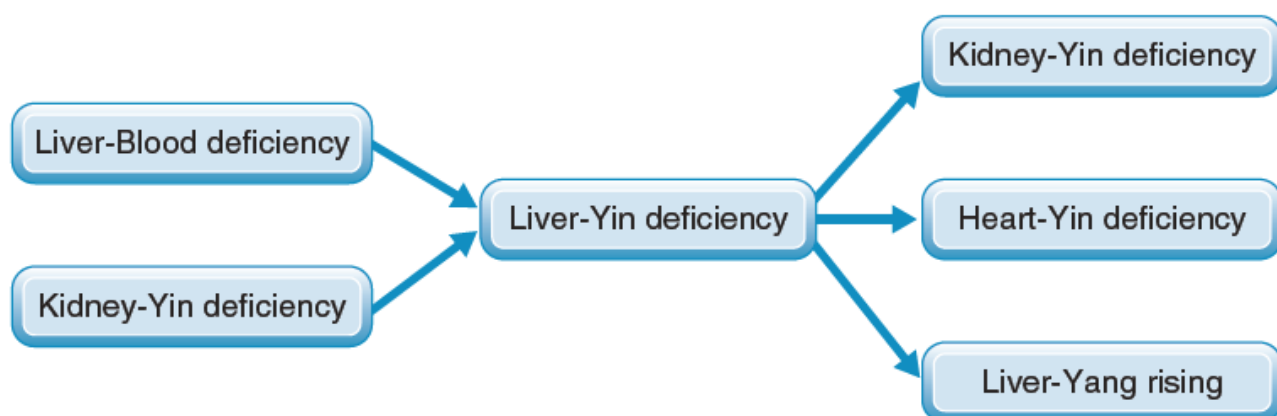
התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

חוסר יין בכבד עלול להשפיע על הכליות ולהוביל לחוסר יין בכליות. חוסר יין בכבד עלול גם לגרום בקלות לעליית יאנג הכבד.

לבסוף, יין הכבד משפיע על יין הלב, ולכן חוסר יין בכבד עלול לגרום לחוסר יין בלב.

עקרונות טיפול:

חיזוק הכבד, הזנת יין וסילוק חום ריק במידת הצורך.



שיטה: חיזוק (למעט LIV-2), ללא מוקסה.

נקודות:

– ארבע הנקודות הראשונות, SP-6, ST-36, LIV-8, ו- Ren-4 זהות לאלה המשמשות להזנת דם הכבד.

– KI-3 ו- KI-6 משמשות להזנת הכליות וה יין של הכבד.

– LIV-2, בשיטת הפחתה, משמשת במקרה של חום ריק.

דפוסים מלאים/ ריקים:

1

Liver-Yang rising – עליית יאנג הכבד

תסמינים קליניים:

כאב ראש, אשר עשוי להופיע ברקות, בעיניים או בצדדים
החיצוניים של הראש, סחרחורת, טינטון, חירשות, ראייה מטושטשת, יובש בפה ובגרון, נדודי שינה, עצבנות,
נטייה להתפרצויות זעם, נוקשות בצוואר .
לשון: מראה הלשון עשוי להשתנות במידה רבה בהתאם למצב הבסיסי הגורם לעליית יאנג הכבד.
אם זה נובע מחוסר דם בכבד, צבע הלשון יהיה חיוור; אם זה נובע מחוסר יין בכבד, הלשון תהיה ללא ציפוי.
במקרים מסוימים, עליית יאנג הכבד עשויה להתפתח ממרדנות צ'י הכבד: במקרה זה צבע הלשון עשוי להיות
רגיל או מעט אדום בצדדים.
דופק: מיתרי. עם זאת, אם יש רקע של חוסר דם בכבד או יין בכבד, הדופק עשוי להיות מיתריק בצד אחד או
שהוא עשוי להיות מתוח אך דק.
תסמינים עיקריים: כאב ראש, עצבנות, דופק מיתרי.

אטיולוגיה:

מתח נפשי הוא הגורם השכיח ביותר לעליית יאנג הכבד.
מתח, כעס ותסכול לאורך זמן גורם לעליית צ'י, מה שמביא לתנועה מוגברת של צ'י הכבד כלפי מעלה.
תזונה:
אכילה בחיפזון, כעס בזמן הארוחות ואכילה תוך כדי עבודה עלולים לגרום לעלייה של צ'י הכבד,
מה שמוביל לדפוס של עלייה ביאנג הכבד.

פתולוגיה:

זהו דפוס מעורב של חוסר/עודף, שכן הוא נובע מחוסר בין הכבד ו/או בין הכליות או בדם הכבד, הגורם לעלייה
ביאנג הכבד.
כאשר יין הכבד נובע מחוסר בכליות, במונחי חמשת האלמנטים, המים חסרים ואינם מצליחים ל"הכניע"
את העץ, אשר הופך יבש מדי וגורם לעלייה של יאנג הכבד.
לכן, דפוס זה מאופיין בחוסר איזון בין יין הכבד (שהוא חסר) לבין כבד-יאנג (שנמצא בעודף).
דפוס זה הוא סוג של צ'י כבד מרדני המאופיין בעלייה מוגזמת של כבד-יאנג. למרות שישנם כמה תסמינים של
חום (כגון גרון יבש), דפוס זה אינו דפוס של חום מלא, אלא פשוט חוסר איזון בין יין ויאנג עם עלייה מוגזמת של
צ'י.
התופעות שתוארו לעיל הן רק תופעות של עליית יאנג הכבד. בפועל, הן מופיעות בדרך כלל יחד עם תסמינים
וסימנים של חוסר יין בכבד ו/או בכליות או חוסר דם בכבד.

ההבדל העיקרי בין דפוס עליית יאנג הכבד לבין דפוס התלקחות אש הכבד הוא שבדפוס התלקחות אש הכבד יש אש "חזקה" המייבשת את נוזלי הגוף ומביאה לתסמינים וסימנים של יובש כגון עצירות, שתן מועט וכהה, עיניים ופנים אדומות וטעם מר, אשר אינם קיימים בדפוס עליית יאנג הכבד.

אש הכבד היא דפוס עודף מובהק, בעוד שעליית יאנג הכבד היא דפוס משולב של חוסר / עודף המאופיין בחוסר איזון בין יין ויאנג ובעליית צ'י, ללא אש "מוצקה".

רוב התופעות נובעות מעליית יאנג הכבד לראש: טינטון, חירשות (שתיהן מתחילות בפתאומיות), נטייה להתפרצויות זעם וכאבי ראש.

כאב הראש הוא אחד הסימנים הנפוצים והבולטים ביותר לעליית יאנג הכבד, ולהפך, עליית יאנג הכבד היא הגורם הנפוץ ביותר לכאבי ראש כרוניים.

כאב הראש הנגרם מעליית יאנג הכבד מופיע בדרך כלל באחת מהרקות, אך הוא יכול להופיע גם בצד הראש (ערוץ כיס המרה) או בתוך העין או מעליה.

הרפואה הסינית גורסת כי מצב של עודף מתבטא לרוב בצד ימין, ואילו מצב של חוסר מתבטא לרוב בצד שמאל. במקרה של עליית יאנג הכבד, הוא יתבטא לרוב בצד ימין, אך אין זו כלל כלל חוק מוחלט. כאב הראש מתאפיין בפעילות.

הלשון והדופק יכולים להראות במגוון דרכים שונות, בהתאם למצב הבסיסי הגורם לעליית יאנג הכבד.

קודמים פתולוגיים של דפוס:

עליית יאנג הכבד נובעת תמיד ממצב אחר, שיכול להיות חוסר יין הכבד, חוסר יין הכליות, או חוסר דם הכבד. כאשר זה נובע מחוסר בכליות, בדרך כלל עליית יאנג הכבד היא תוצאה של חוסר יין הכליות/ הכבד-יין, אך בפועל, הוא יכול לנבוע גם מחסר בכליות-יאנג. הסיבה לכך היא שכליות-יין וכליות-יאנג הם בעלי אותו שורש, וחסר באחד מהם תמיד מרמז על חסר בשני (אם כי בדרגה פחותה). לכן, כאשר יאנג הכליות-חסר, כך גם יין הכליות יהיו חסרות במידה מסוימת ועלול לגרום לתסמינים של עלייה ביאנג הכבד.

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

עליית יאנג הכבד עשויה, עם הזמן, להתפתח לאש הכבד, במיוחד אם החולה ניזון מתזונה הכוללת צריכה מוגזמת של מזונות בעלי אנרגיה חמה. עליית יאנג הכבד עשויה גם לגרום, עם הזמן, להתפתחות רוח הכבד, במיוחד בקרב קשישים.

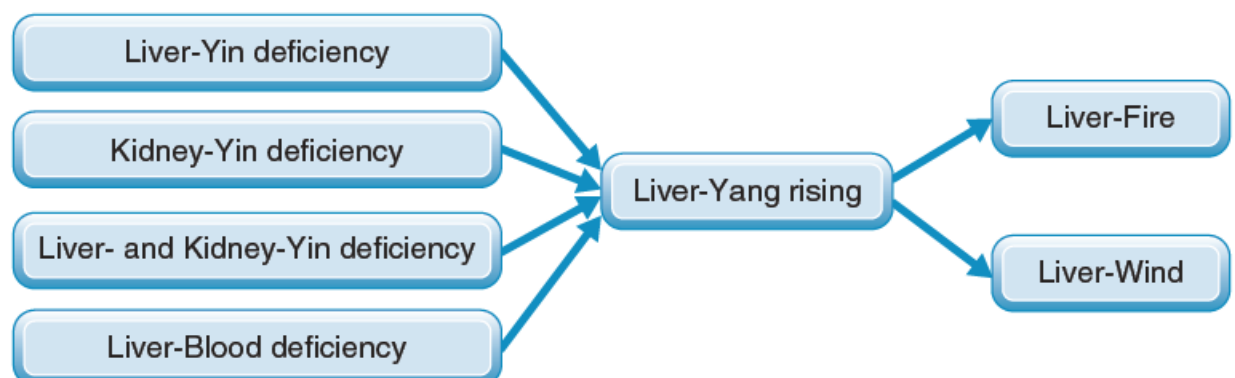


Table 34.2 Comparison between Liver-Yang rising and Liver-Fire

	Liver-Yang rising	Liver-Fire	Common characteristic
Aetiology	Emotional stress	Emotional stress and diet	Excessive ascending of Liver-Qi
Pathology	Imbalance between Yin and Yang, excessive ascending of Liver-Qi, no real Heat	Full-Heat	
Eight Principles	–	Full-Heat	
Symptoms	Headaches	Headaches and eye problems	
Treatment principle	Subdue Liver-Yang	Drain Fire	
Herbal treatment method	Sweet herbs to correct flow of Liver-Qi, sinking herbs to subdue Yang	Bitter-cold herbs to drain Fire	

עקרון הטיפול: להרגיע את יאנג הכבד, להזין את יין או את הדם.

שיטה: שיטת הפחתה בנקודות כדי להרגיע את יאנג הכבד ושיטת חיזוק בנקודות כדי להזין יין או דם.

נקודות:

- LIV-3 מרגיע את יאנג הכבד. זהו הנקודה הדיסטלית העיקרית שיש להשתמש בה.
- T.B.-5 מרגיע את יאנג הכבד והוא מתאים במיוחד לכאבי ראש לאורך תעלת כיס המרה.
- P-6 עוזר להרגיע את יאנג הכבד ומרגיע את הנפש.
- L.I.-4 מווסת את העלייה והירידה של הצי' ולכן מסייע בדיכוי יאנג הכבד.
- G.B.-43 היא הנקודה הדיסטלית העיקרית לכאבי ראש סביב העין או הרקה.
- G.B.-38 היא נקודה דיסטלית לדיכוי יאנג הכבד והיא משמשת לעתים קרובות לכאבי ראש, מיגרנה למצבים כרוניים ועיקשים.
- G.B.-20 היא נקודה סמוכה חשובה לדיכוי יאנג הכבד
- BL-2, Taiyang, G.B.-9, G.B.-8 ו-G.B.-6 הן כולן נקודות מקומיות חשובות לכאבי ראש הנובעים מעליית - יאנג הכבד, הנבחרות בהתאם למיקום כאב הראש.
- SP-6, LIV-8 ו-ST-36 מזינים את דם הכבד ואת יין הכבד.
- KI-3 ו-KI-6 משמשים במקרה של חסר ביין הכליות.

Liver-Wind agitating within – רוח פנימית של הכבד

ישנם ארבעה סוגים שונים של רוח בכבד, הנובעים מארבע סיבות שונות.
אלה הם:

1. חום קיצוני המייצר רוח
2. עליית יאנג הכבד המייצרת רוח
- א) עליית יאנג הכבד הנובעת מחוסר יין הכבד
- ב) עליית יאנג הכבד הנובעת מחוסר יין הכבד והכליות
- ג) עליית יאנג הכבד הנובעת מחוסר דם הכבד
3. אש הכבד המייצרת רוח
4. חוסר דם הכבד המייצר רוח

הביטויים הקליניים הכלליים של רוח הכבד:

רעד, טיקים, חוסר תחושה, סחרחורת ועוויתות או שיתוק.
סימני רוח פנימית מאופיינים בתנועה או בהיעדרה, ומכאן הרעד והעוויתות או השיתוק (כמו בשבץ רוח).
רוח פנימית קשורה תמיד לכבד, שכן העוויתות והרעד מוסברים ברפואה הסינית כ"רעד" של הגידים, הנשלטים על ידי הכבד.

1. חום קיצוני המייצר רוח

תסמינים קליניים:

חום גבוה, עוויתות, נוקשות בצוואר, רעד בגפיים, אופיסוטונוס, במקרים חמורים תרדמת.

לשון: אדומה עמוקה, נוקשה, ציפוי צהוב יבש.

דופק: מהיר ומיתרי

* Opisthotonos בעברית: צפידת גב (הוא מצב רפואי חמור של התכווצות שרירים עוויתית, הגורמת לגב ולצוואר להתקשת אחורה בצורה קיצונית ונוקשה. במצב זה, האדם נשען רק על ראשו ועקביו, כשהגוף קשתי. זהו אינו מחלה בפני עצמה, אלא תסמין לבעיות נוירולוגיות חריפות.

אטיולוגיה:

דפוס זה נובע מפלישה של רוח-חום חיצונית, המתחלפת לאחר מכן לחום פנימי. כאשר החום מגיע לרמת הדם, הוא עלול להוביל להתפתחות של רוח פנימית. סוג זה של רוח נצפה במחלות חום כגון דלקת קרום המוח.

פתולוגיה:

כאשר החום מגיע לרמת הדם במחלות חום, הוא פוגע ביין, וחוסר היין גורם לרוח פנימית.

עקרון הטיפול: לקרר את הדם, להזין את היין, להרגיע את הרוח.

שיטה: שיטת הפחתה, דימום מנקודות Shixuan

– LIV-3 מרגיעה את רוח הכבד.

– נקודות Shixuan (בקצות כל אצבע) מרגיעות את הרוח ומקררות את הדם כאשר הן נדקרות כדי לגרום לדימום. הקזה

– Du-16, Du-20, G.B.-20 מסלקים את הרוח.

– Du-8 מקל על עוויתות כדי לעצור פרכוסים.

– Du-14 נדקר כדי לקרר את הדם.

2. עליית יאנג הכבד המייצרת רוח

עליית יאנג הכבד עלולה ליצור רוח אם היא נמשכת במשך כמה שנים. בדרך כלל זה קורה רק אצל קשישים. אנו יכולים להבחין בין התופעות הקליניות בהתאם לסיבת עליית יאנג הכבד, כלומר:

- עליית יאנג בכבד הנובעת מחוסר יין בכבד
- עליית יאנג בכבד הנובעת מחוסר יין בכבד ובכליות
- עליית יאנג בכבד הנובעת מחוסר דם בכבד

עלייה של יאנג בכבד הנובעת מ חוסר יין בכבד

תופעות קליניות:

רעד, טיק בפנים, סחרחורת חמורה, טינטון, כאב ראש, יתר לחץ דם, יובש בגרון, יובש בעיניים, ראייה מטושטשת, חוסר תחושה או עקצוץ בגפיים, זיכרון לקוי.
לשון: צבע רגיל ללא ציפוי.
דופק: דק ומיתרי.

עקרון הטיפול: להרגיע את יאנג הכבד, לסלק את הרוח, להזין את יין הכבד.
שיטה: הפחתה/ פיזור בנקודות לסילוק הרוח וחיזוק בנקודות המזינות את יין הכבד.
– LIV-3 מרגיע את יאנג הכבד ומכבה את הרוח.
– G.B.-20 מכבה את הרוח ומרגיע את יאנג.
– L.I.-4 עוזרת לריסון יאנג.
– T.B.-5 מרגיע את יאנג הכבד.
– Du-19 מכבה את הרוח.
– SP-6, KI-3 ו-LIV-8 מזינים את יין הכבד.
– Du-19 מכבה את הרוח.
– SP-6, KI-3 ו-LIV-8 מזינים את יין הכבד.

עלייה ביאנג הכבד הנובעת מחוסר יין בכבד והכליות.

תסמינים קליניים:

רעד, טיק בפנים, סחרחורת חמורה, טינטון, כאב ראש, יובש בגרון, יובש בעיניים, ראייה מטושטשת, חוסר תחושה או עקצוץ בגפיים, זיכרון לקוי, כאבי גב, מתן שתן מועט, הזעת לילה, ייתכן גם יתר לחץ דם.
לשון: צבע רגיל ללא ציפוי.
דופק: דק ומיתרי.

עקרון הטיפול: להרגיע את יאנג הכבד, למתן את הרוח, להזין את יין הכבד והכליות.
נקודות: LIV-3 Taichong, G.B.-20 Fengchi, L.I.-4 Hegu

,T.B.-5 Waiguan, Du-19 Houding, SP-6 Sanyinjiao

LIV-8 Ququan, KI-3 Taixi, KI-6 Zhaohai, Ren-4

.Guanyuan

שיטה: הפחתה בנקודות המכבות את הרוח ומרגיעות את היאנג, וחיזוק בנקודות המזינות את הכבד והכליות-יין.
הסבר:

– שמונה הנקודות הראשונות הוסברו בתבנית הקודמת.

– KI-6 ו-Ren-4 מזינות את הכליות-יין.

עלייה של יאנג בכבד הנובעת מ חוסר בדם בכבד

תופעות קליניות:

רעד, סחרחורת, טינטון, כאב ראש, יתר לחץ דם, יובש בגרון, ראייה מטושטשת, חוסר תחושה או עקצוץ בגפיים, זיכרון לקוי, נדודי שינה.

לשון: חיוורת ודקה.

דופק: מיתרי ודק.

עקרון הטיפול: להרגיע את יאנג הכבד, להשקיט את הרוח, להזין את דם הכבד.

נקודות: LIV-3 Taichong, G.B.-20 Fengchi, L.I.-4 Hegu

,T.B.-5 Waiguan, Du-19 Houding, SP-6 Sanyinjiao

LIV-8 Ququan, KI-3 Taixi, BL-17 Geshu, Ren-4

.Guanyuan

שיטה: הפחתה בנקודות המרגיעות את היאנג ומכבות את הרוח, חיזוק בנקודות המזינות את דם הכבד.
הסבר

– שמונה הנקודות הראשונות הוסברו בתבנית הקודמת.

– BL-17 מזינה את הדם.

– Ren-4 מזינה את הדם.

3.אש בכבד המייצרת רוח

תסמינים קליניים:

רעד, עצבנות, נטייה להתפרצויות זעם, טינטון ו/או חירשות (בהופעה פתאומית), כאב ראש זמני, סחרחורת, פנים ועיניים אדומות, צמא, טעם מר, שינה מופרעת על ידי חלומות, עצירות עם צואה יבשה, שתן צהוב כהה, דימום מהאף, הקאות דם, שיעול דם.

לשון: אדומה עם צדדים אדומים יותר וציפוי צהוב יבש.

דופק: מהיר ומיתרי

האטיולוגיה של דפוס זה זהה לזו של דפוס אש הכבד שנדון לעיל.

פתולוגיה:

אש הכבד עלולה ליצור רוח כאשר היא נמשכת מספר שנים:
תופעה זו שכיחה יותר בקרב קשישים. תופעה זו דומה לשריפת יער המניעה רוחות. זהו דפוס של חום מלא.
עקרון הטיפול: לנקות את הכבד, לנקז את האש, לכבות את הרוח.
שיטה: שיטת הפחתה, ללא מוקסה.

- LIV-2 מנקז את אש הכבד.
- LIV-3 מכבה את רוח הכבד.
- G.B.-20 מכבה את הרוח.
- L.I.-11 מנקז אש.
- G.B.-1 מכבה רוח הכבד.
- SP-6 משמש להזנת יין כדי לסייע בניקוז אש.
- LIV-1 מכבה רוח הכבד.
- Du-8 מקל על עוויתות ורעידות.

4. חסר בדם הכבד הגורם לרוח:

תסמינים קליניים:
רעד עדין, טיק בפנים, סחרחורת, ראייה מטושטשת, חוסר תחושה או עקצוץ בגפיים, זיכרון לקוי, נדודי שינה, מחזור מועט.
לשון: חיוורת ודקה.
דופק: מיתרי ודק.
האטיולוגיה של דפוס זה זהה לזו של חוסר דם בכבד.
פתולוגיה:
חוסר דם בכבד עלול להוביל להתפתחות רוח פנימית, שכן המקום שתופס בדרך כלל הדם בכלי הדם "נתפס" על ידי הרוח. בעוד שהדפוס הקודם של רוח (אש הכבד המייצרת רוח) ניתן להשוואה לרוח הנוצרת על ידי שריפת יער, בדפוס זה ניתן להשוות את הרוח לרוחות החזקות הנוצרות על ידי החללים הריקים בתחנות הרכבת התחתית.
כאשר הרוח נובעת מחוסר דם בכבד, הרעידות פחות בולטות מאשר ברוח מלאה.

עקרון הטיפול: להזין את הכבד והדם, לכבות את הרוח.
שיטה: הפחתה בנקודות המכבות את הרוח, חיזוק בנקודות המזינות את דם הכבד.
ניתן להשתמש במוקסה ב-BL-17.
– LIV-3 ו-G.B.-20 מכבים את הרוח.
– L.I.-4 מסייע לריסון היאנג ולכן מכבה את הרוח.
– T.B.-5 ו-Du-19 מכבים את רוח הכבד.
– SP-6, LIV-8 ו-KI-3 מזינים את דם הכבד.
– Ren-4 ו-BL-17 מזינים את הדם.

דפוסים משולבים

- צ'י הכבד המרדני הפולש לטחול
 - צ'י הכבד המרדני הפולש לקיבה
 - אש הכבד הפוגעת בריאות
 - חוסר דם בלב ובכבד
- חוסר יין בכבד ובכליות – מופיע בפרק של כליות 37

צ'י הכבד המרדני הפולש לטחול

עצבנות, נפיחות וכאבים בבטן, לסירוגין עצירות ושלשולים, צואה יבשה לעיתים וקטנה (חתיכות קטנות) ולעיתים רכה, גזים, עייפות.

לשון: צבע רגיל או אדמדם מעט בצדדים.

דופק: מיתרי בצד שמאל וחלש בצד ימין.

תסמינים עיקריים: עצירות ושלשולים לסירוגין, נפיחות וכאבים בבטן, דופק מיתרי

אטיולוגיה:

מתח נפשי: דפוס זה נגרם בדרך כלל על ידי בעיות רגשיות המשפיעות על הכבד, כגון כעס, תסכול וטינה. רגשות אלה, לאורך זמן רב, גורמים לקיפאון של צ'י הכבד, מה שמפריע לתפקוד הטחול ומונע את עליית צ'י הטחול.

תזונה:

אכילה לא סדירה, ובמיוחד אכילה בחיפזון, כאשר מודאגים, כועסים או בזמן העבודה, עלולה לגרום למרד של צ'י הכבד כלפי הטחול ולפגיעה ב T&J של הטחול.

פתולוגיה:

הכבד אחראי על זרימה חלקה של צ'י בכל הגוף. כאשר צ'י הכבד הופך למרדן (כלומר, תנועתו האופקית לכיוון הטחול מודגשת), הוא לעתים קרובות מפריע לתפקוד הטחול בהתמרה ובהובלה ומונע מצי הטחול לעלות: ברפואה הסינית אומרים שה"כבד פולש לטחול", או ש"הכבד והטחול אינם בהרמוניה".

במונחי חמשת האלמנטים, זה מתאים לעץ הפועל יתר על המידה על האדמה.

במונחי שמונה העקרונות, זהו דפוס של חוסר עודף מעורב: עודף של הכבד (צ'י הכבד המרדני) וחוסר של צ'י הטחול.

כאשר צ'י הכבד המרדני שולט, ישנה עצירות עם צואה יבשה, קשה וקטועה. כאשר חוסר הטחול שולט, ישנה צואה רכה. הנפיחות והכאב בבטן נגרמים על ידי קיפאון צ'י הכבד בבטן.

נפיחות היא התסמין האופייני ביותר לצי מורד של הכבד.

ייתכן שיהיה גם כאב (בדרך כלל 'כאב מתנפח'), אך לא חמור.

דפוס זה יכול להופיע בשתי מצבים שונים המאופיינים בדגשים שונים. במצב אחד הכבד נמצא בעיקר בעודף ומרדני והוא "פולש" באופן פעיל לטחול, מפריע לתפקודו בתהליך ההתמרה וההובלה.

דפוס זה הוא אפוא בעיקר דפוס של עודף: יש עצירות בתדירות גבוהה יותר מאשר שלשול, והנפחות והכאב בבטן בולטים למדי.

במצב השני הטחול נמצא בעיקר במצב של חוסר ומאפשר לכבד לפלוש אליו. דפוס זה הוא בעיקר דפוס של חוסר: יש לרוב שלשולים יותר מאשר עצירות והכאב הבטן הוא קל בלבד.

זה מסביר מדוע הלשון יכולה להיות אדומה בצידה או בצבע רגיל.

במקרה הראשון, כאשר הכבד פולש באופן פעיל לטחול, היא תהיה אדומה בצידה.

במקרה השני, כאשר הטחול חלש ומאפשר לכבד לפלוש אליו, הלשון תהיה בצבע רגיל.

תסמינים מוקדמים פתולוגיים של דפוס:

צ'י הכבד המרדני יכול להתפתח תקיעות של צ'י הכבד.

התפתחויות פתולוגיות של הדפוס:

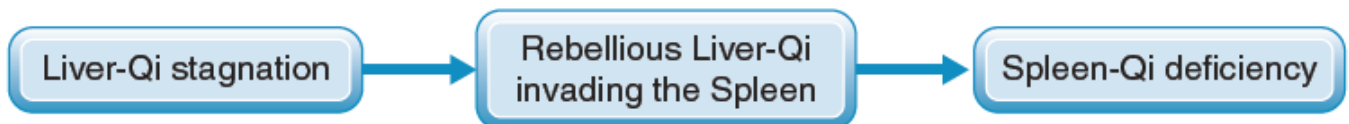
כאשר הוא נמשך לאורך זמן, צ'י מורד של הכבד עלול להחליש את הטחול, ולגרום לחוסר בצ'י הטחול, ובמקרים מסוימים, אף לחוסר בין הטחול.

השילוב של צ'י הכבד המרדני עם אובדן זרימת הצ'י החופשית ומחסור בצ'י הטחול עלול להוביל לפגיעה בהובלה ובשינוי של נוזלים ולהיווצרות לחות.

השילוב של שלושת הגורמים הללו, צ'י הכבד המרדני, מחסור בטחול ולחות, נפוץ מאוד בתסמונת המעי הרגיז.

עקרון הטיפול: להרגיע את הצ'י המורד, לחזק את הטחול.

שיטה: הפחתה בנקודות שמאזנות את הכבד, חיזוק בנקודות כדי לחזק את הטחול.



נקודות:

– LIV-13 מביא לאיזון בין הכבד לטחול.

– LIV-14 מביא לאיזון בין הכבד ומקדם את הזרימה החלקה של צ'י הכבד.

– LIV-3 מקדם את הזרימה החלקה של צ'י הכבד ומרגיע כאבי בטן.

– G.B.-34 מקדם את הזרימה החלקה של צ'י הכבד

ובשילוב עם Qihai Ren-6, מרגיע כאבי בטן.

– Ren-6 עוצר כאבי בטן ובשילוב עם G.B.-34, מניעה את הצ'י בבטן.

– T.B.-6 ו-P-6 מזיזים את צ'י הכבד ומרגיעים את הנפש.

– ST-25 ו-SP-15 מביאים להרמוניה בין הכבד והטחול ומטפלים הן בעצירות והן בצואה רכה.

– ST-36 ו-Ren-12, SP-6 מחזקים את הטחול. SP-6 גם מביא להרמוניה בין הכבד והטחול ומפסיק

כאבי בטן.

– SP-4 ו-P-6 בשילוב פותחים את (Chong Mai) ומביאים להרמוניה בין הכבד והטחול, במיוחד במחלות עיכול.

צ'י הכבד המרדני הפולש לקיבה

עצבנות, נפיחות וכאבים באזור הבטן העליונה והיפוכונדריאלית תחושת לחץ באזור הבטן העליונה, הקאות חומציות, שיהוקים, גיהוקים, בחילות, הקאות, אנחות, חולשה בגפיים.

לשון: צבע רגיל או אדמדם מעט בצדדים.

דופק: מיתרי בצד שמאל וחלש בצד ימין או חזק בשני הצדדים האמצעיים.

אטיולוגיה: גם דפוס זה נגרם על ידי בעיות רגשיות בשילוב עם תזונה לא סדירה ועומס יתר, באותו אופן כמו בדפוס הקודם.

פתולוגיה:

דפוס זה מאופיין ב-Qi של מורד הכבד הפולש לקיבה ומפריע לירידה של Qi של הקיבה:

התוצאה היא עלייה של Qi של הקיבה, ומכאן הגיהוקים, הבחילות וההקאות.

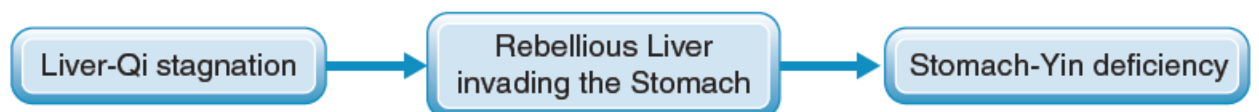
הצ'י המרדני של הכבד במבער האמצעי גם מפריע לריקבון הקיבה ולהבשלה של המזון, מה שמביא להתנפחות באזור הבטן העליונה ולריפלוקס חומצי.

ה-Liver-Qi המרדני גורם לנפיחות, כאב ורגזנות.

אותם הדברים שנאמרו על הכבד הפולש לטחול חלים על דפוס זה ביחס לשתי האפשרויות של ביטוי הלשון.

מסיבה זו, הלשון עשויה להיות אדומה בצדדים אם ה-Liver-Qi הוא זה הפולש בעיקר לקיבה.

או בצבע רגיל אם הקיבה חלשה בעיקר ומאפשרת לכבד לפלוש אליה.



תסמינים מוקדמים של הדפוס:

צ'י מורד של הכבד עלול להתפתח מתקיעות של צ'י הכבד.

התפתחויות פתולוגיות מדפוס:

צ'י מורד של הכבד עלול להחליש את הקיבה אם נמשך לאורך זמן עד כדי פגיעה בין הקיבה

עקרון הטיפול: להרגיע את צ'י הכבד ולחזק את הקיבה.

נקודות:

– LIV-14 מהרמנת כבד במ. אמצעי. ובפרט, LIV-14 מביא להרמוניה בין הכבד והקיבה.

– G.B.-34 מביא להרמוניה בכבד, מעודדת את הזרימה החלקה של צ'י הכבד, במיוחד ב היפוכונדריה.

– Ren-13 מרגיע את צ'י הקיבה העולה המורד.

– Ren-10 מחזקת את הירידה של צ'י הקיבה.

– ST-21 ו-ST-19 גורמים לצ'י הקיבה לרדת.

– ST-36 מחזק את הקיבה.

– ST-34 לכאבים ברום הבטן.

– BL-21 לחיזוק הקיבה במיוחד במקרים כרוניים.

אש הכבד פוגעת בריאות

תסמינים קליניים:

קוצר נשימה, אסטמה, תחושת מלאות ונפיחות בחזה ובבית החזה, שיעול עם ליחה צהובה או דמית, כאבי ראש, סחרחורת, פנים אדומות, צמא, טעם מר, עיניים אדומות, שתן כהה מועט, עצירות.

לשון: אדומה עם צדדים אדומים יותר וציפוי צהוב יבש.

דופק: מיתרי

תסמינים עיקריים: קוצר נשימה, אסטמה, מלאות בבית החזה, כאב ראש, דופק מיתרי

אתיולוגיה:

דפוס זה נגרם על ידי כעס, הגורם להיווצרות של אש בכבד, בדרך כלל לאחר תקופה ממושכת של סטגנציה של צ'י הכבד.

הוא מחמיר גם על ידי צריכה מוגזמת של מזונות חמים ושומניים, הנוטים ליצור חום.

פתולוגיה:

הכבד שולט בזרימה החלקה של הצ'י: יש לכך השפעה על ירידת הצ'י של הריאות.

אם הצ'י של הכבד עומד במקום לאורך זמן, הוא הופך לאש הכבד.

האש נוטה לעלות ולכן הצ'י של הכבד מתמרד כלפי מעלה לכיוון החזה.

כאן הוא מונע מהצ'י של הריאות לרדת, מה שמביא לקוצר נשימה ואסטמה.

הקיפאון של צ'י הכבד גורם לתחושת נפיחות בחזה ובבית החזה.

עליית אש הכבד גורמת לכאבי ראש, סחרחורת, אדמומיות בפנים, עיניים אדומות, צמא וטעם מר.

אש בגוף מעבה את הנוזלים וגורמת לשתן עכור וכהה ולעצירות;

אם האש נכנסת לדם, היא מחממת את הדם וגורמת לדימום ולכן לכיח מלווה בדם.

מנקודת המבט של חמשת היסודות, דפוס זה מתואר כעץ מעליב מתכת.

הצבע האדום בצידי הלשון משקף את נוכחות אש הכבד.

תסמינים מוקדמים פתולוגיים של דפוס זה:

בדרך כלל, אש הכבד עלולה להתפתח (אך לא בהכרח) מקיפאון ממושך של צ'י הכבד. עליית יאנג הכבד עלולה גם להפוך לאש הכבד.

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

דפוס זה עלול לגרום לתוצאות פתולוגיות שונות בשל הפתולוגיה המורכבת יחסית שלו.

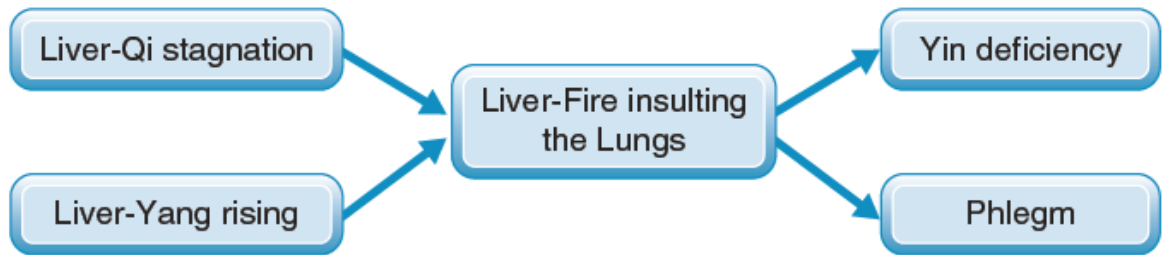
ראשית, אש הכבד עלולה לייבש את נוזלי הגוף ולהוביל למחסור ביין. על ידי עיבוי נוזלי הגוף, האש עלולה

גם להוביל להיווצרות ליחה, כאשר מצב זה מתפתח זה ישבש את מנגנון הצ'י ונראה פגיעה בירידת צ'י הריאות

ועלייה מוגזמת של צ'י הכבד.

בהתחשב ביחסי אש-יילד בין חמשת היסודות בין עץ ואש, הכבד משפיע על הלב

ולכן אש הכבד גורמת לעתים קרובות לאש הלב.



עקרונ הטיפול: לנקות את הכבד, לנקז את האש, לרסן את צ'י הכבד, לעורר את ירידת צ'י הריאות.

שיטה: הפחתה.

- LIV-2 מטהר את אש הכבד.
- LIV-3 מרגיע את צ'י הכבד.
- LIV-14 מביא להרמוניה בין צ'י הכבד בחזה.
- Ren-17 ו-Ren-22 מעוררים את ירידת ה-Lung-Qi.
- P-6 מביא להרמוניה בין ה-Liver-Qi בחזה (בזכות הקשר בין הכבד והפריקרדיום בתוך ה-Terminal Yin) ומגרה את ירידת ה-Lung-Qi.
- LU-7 מגרה את ירידת ה-Lung-Qi.
- LI-11 מטהר חום.

חוסר בכבד ובדם הלב

תסמינים קליניים:

דפיקות לב, סחרחורות, נדודי שינה, הפרעות שינה, זיכרון לקוי, חרדה, נטייה להבהל, עור חיוור, שפתיים חיוורות, ראייה מטושטשת, כתמים צפים בעיניים, ירידה בראייה בלילה, עקצוץ או חוסר תחושה בגפיים, מחזור מועט או אמנוריה, התכווצויות, חולשת שרירים, שיער ועור יבשים, דיכאון, תחושת חוסר תכלית, ציפורניים יבשות ושבירות.

לשון: חיוורת, דקה, מעט יבשה.

דופק: מחוספס או דק

תסמינים עיקריים: דפיקות לב, סחרחורות, ראייה מטושטשת, נדודי שינה, זיכרון לקוי, לשון חיוורת.

אטיולוגיה:

מתח נפשי, חרדה, דאגה, עצב וצער משפיעים על הלב ועשויים לגרום לחוסר בדם הלב. דאגה ועצב עשויים להשפיע גם על הכבד, ולגרום לחוסר בדם הכבד.

תזונה: תזונה דלה במזון מזין ובמזונות המזינים את הדם עשויה להוביל לחוסר בדם הכבד.

עבודה גופנית מוגזמת: עבודה גופנית מוגזמת עלולה לפגוע בגידים ובכך בדם הכבד. ריצה מוגזמת עלולה לפגוע בדם הלב.

איבוד דם: איבוד דם חמור, כגון זה שעלול להתרחש בלידה, עלול לדלדל את דם הכבד, וכתוצאה מכך עלול לגרום לחוסר בדם הלב.

פתולוגיה:

הפתולוגיה של הדפוסים האישיים של חוסר בדם הלב ובדם הכבד נדונה תחת הדפוסים הרלוונטיים (פרק 32 לדפוסים של הלב).

השילוב של חוסר בדם הלב ובדם הכבד הוא נפוץ מאוד, במיוחד אצל נשים. אכן, הלב והכבד הם שני האיברים העיקריים הסובלים מחוסר בדם, שכן הלב שולט בדם והכבד מאחסן אותו.

דם הלב ודם הכבד משפיעים זה על זה,

ובחלק מהתופעות הקליניות, יש חפיפה ביניהם, כך שניתן לייחס אותן לפתולוגיה של כל אחד מהאיברים. לדוגמה, נדודי שינה עשויים להיות מיוחסים לחוסר בדם הלב או בדם הכבד, מכיוון שהנפש (שן) והנשמה האתרית (הון) ישנו תפקיד בשינה.

הנפש מעוגנת בדם הלב, והנשמה האתרית בדם הכבד: כאשר אחד מהם חסר, הנפש או הנשמה האתרית "משוטטות" בלילה, וגורמות לנדודי שינה. נדודי השינה הנגרמים מחוסר בדם הכבד מאופיינים בחלומות רבים יותר.

סחרחורת היא תופעה נוספת שיש בה חפיפה, שכן היא עלולה להיגרם מחוסר בדם הלב או מחוסר בדם הכבד.

שני התסמינים העיקריים של מחסור בדם הלב ובדם הכבד, בהתאמה, הם דפיקות לב וראייה מטושטשת.

באופן כללי, שילוב זה של דפוסים נוטה להתחיל עם חוסר בדם הכבד ולא עם חוסר בדם הלב. מכיוון שנשים נוטות יותר לסבול מחוסר בדם הכבד מאשר גברים, שילוב זה של דפוסים נפוץ יותר בקרב נשים, שם מחזור מועט הוא סימפטום של חוסר בדם הכבד.

שילוב של מחסור בדם הלב ובדם הכבד נפוץ לעתים קרובות בדיכאון לאחר לידה. אם האישה סובלת מאובדן דם חמור בלידה (או "חמור" ביחס לרמות דם הכבד שהיו לה לפני כן), זה עלול לגרום למחסור בדם הכבד; מכיוון שהכבד הוא "אמא" של הלב, זה עלול לגרום למחסור בדם הלב. חוסר בדם הלב עלול לגרום לאי-יכולת לאכלס את הנפש, והאישה עלולה לסבול מדיכאון ומנדודי שינה.

תסמינים מוקדמים פתולוגיים של דפוס זה:

לפעמים, חוסר בכליות עשוי להיות תסמין מוקדם של שילוב דפוסים זה, במיוחד אצל נשים, ובמיוחד במצבים גינקולוגיים. הכליות הן "אמא" של הכבד, ותמצית הכליות מזינה את דם הכבד. יתר על כן, למרות שהכבד מאחסן דם (ולכן גם דם וסת), הכליות הן מקור הדם הווסטי (Tian Gui) "הטל השמימי".

יש לזכור כי אצל נשים צעירות רבות, חוסר בכליות עלול להתבטא לעיתים פשוט בדופק חלש בשתי עמדות האחוריות.

התפתחויות פתולוגיות לדפוס:

למרות שחוסר בכליות עשוי להיות השורש של שילוב תבניות זה, באופן דומה, חוסר בכבד ובדם הלב

עשוי להוביל לחוסר בכליות, במיוחד אצל נשים.

חוסר דם ממושך בלב ובכבד מוביל ליובש המתבטא בשיער יבש, עור יבש, ציפורניים יבשות וקמולות ושפתיים יבשות.

לבסוף, חוסר דם ממושך בלב ובכבד יוביל לחוסר יין בשני איברים אלה.

עקרון הטיפול: להזין את הדם, לחזק את הלב והכבד, להרגיע את הנפש ולהשקיט את הנשמה האתרית.

שיטה: כל הנק' בחיזוק. ניתן להשתמש במוקסה

נקודות:

HE-7 – מזין את דם הלב ומרגיע את הנפש.

Ren-14 – Ren-15 – מזינים את דם הלב ומרגיעים את הנפש. הם יעילות במיוחד במקרים של חרדה בולטת.

BL-17, Ren-4 – BL-20 – מזינים את הדם BL-17. הוא נקודת האיסוף של הדם ו BL-20 – הוא

נקודת ההובלה האחורית של הטחול מחזקת את צ'י הטחול כדי לייצר יותר דם.

LIV-8, ST-36 – SP-6 – מזינים את דם הכבד.

BL-18 – BL-23 – מזינים את דם הכבד, במיוחד במצבים גינקולוגיים.

חוסר יין בכליות ובכבד

תסמינים קליניים:

סחרחורת, טינטון, קשיי שמיעה, כאבי גב תחתון, כאב ראש עורפי או אנכי עמום, נדודי שינה, חוסר תחושה או עקצוץ בגפיים, יובש בעיניים, ראייה מטושטשת, יובש בגרון, שיער ועור יבשים, ציפורניים שבירות, יובש בנרתיק,

הזעת לילה, צואה יבשה, פליטות לילה, וסת מועטה או אמנוריאה, מחזור מאוחר, עקרות.

לשון: צבע רגיל ללא ציפוי או עם ציפוי ללא שורש.

דופק: צפ-ריק.

תסמינים עיקריים: יובש בעיניים, יובש בגרון, הזעת לילה, וסת מועטה, לשון ללא ציפוי.

חום ריק

חום בחמש כפות הידיים, תחושת חום בערב, גלי חום בגיל המעבר.

לשון: אדומה ללא ציפוי.

דופק: צפ-ריק וקצת מהיר.

אטיולוגיה:

זהה לאטיולוגיה של חוסר יין בכליות וחוסר דם בכבד, אך עם מרכיב נוסף של בעיות רגשיות הנובעות מכעס, תסכול ודיכאון.

הטיפול מתמקד בהחזרת האיזון בין יין ודם, תוך התייחסות לבעיות הרגשיות הנלוות.

פתולוגיה:

דפוס זה כולל תסמינים וסימנים של חוסר יין בכבד ובכליות, תוך התחשבות בכך שחוסר יין בכבד מבטא חוסר דם בכבד.

הכליות מתאימות למים וצריכות להזין את הכבד, המתאים לעץ.

לפיכך, היין והדם של הכבד תלויים בהזנה של יין הכליות ותמצית הכליות (איור 37.22).

יובש בעיניים הוא תסמין של חוסר יין בכבד ודם הכבד. לפיכך, היין והדם של הכבד תלויים בהזנה של יין הכליות ותמצית הכליות (איור 37.22).

עיניים יבשות הן תסמין של חוסר יין בכבד, מכיוון שיין הכבד אינו מסוגל ללחלח את העיניים.

אכן, עיניים יבשות הן אחד התסמינים הבולטים ביותר של חוסר יין בכבד.

שינה מופרעת על ידי חלומות, נדודי שינה, חוסר תחושה, ראייה מטושטשת ווסת מועטה או אמנוריה הם כולם תסמינים של חוסר דם בכבד, שהוא חלק מחוסר יין בכבד.

הכאב הראש נובע גם מחוסר בכבד-דם ויהיה או בעורף (קשור לכליות) או בקצה הראש (קשור לתעלת הכבד).

כאשר יין הכבד חסר, יאנג הכבד עלול לעלות, ובמקרה כזה הכאב הראש יהיה ברקות והוא יהיה פועם ולא עמום.

כל התסמינים האחרים נובעים מחוסר יין בכליות, שכולם כבר הוסברו.

העקרות אצל נשים נובעת הן מחוסר בדם בכבד, שאינו מצליח להזין את הרחם, והן מחוסר באנרגיה בכליות, שאינה מצליחה לקדם את ההפריה. הדופק הוא צף וריק, מה שמשקף את חוסר היין. היעדר ציפוי על הלשון משקף חוסר יין.

דפוס זה עלול להתפתח מחוסר בדם הכבד וב-יין הכבד.

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

התוצאה הנפוצה ביותר של דפוס זה היא התפתחות של חום ריק.

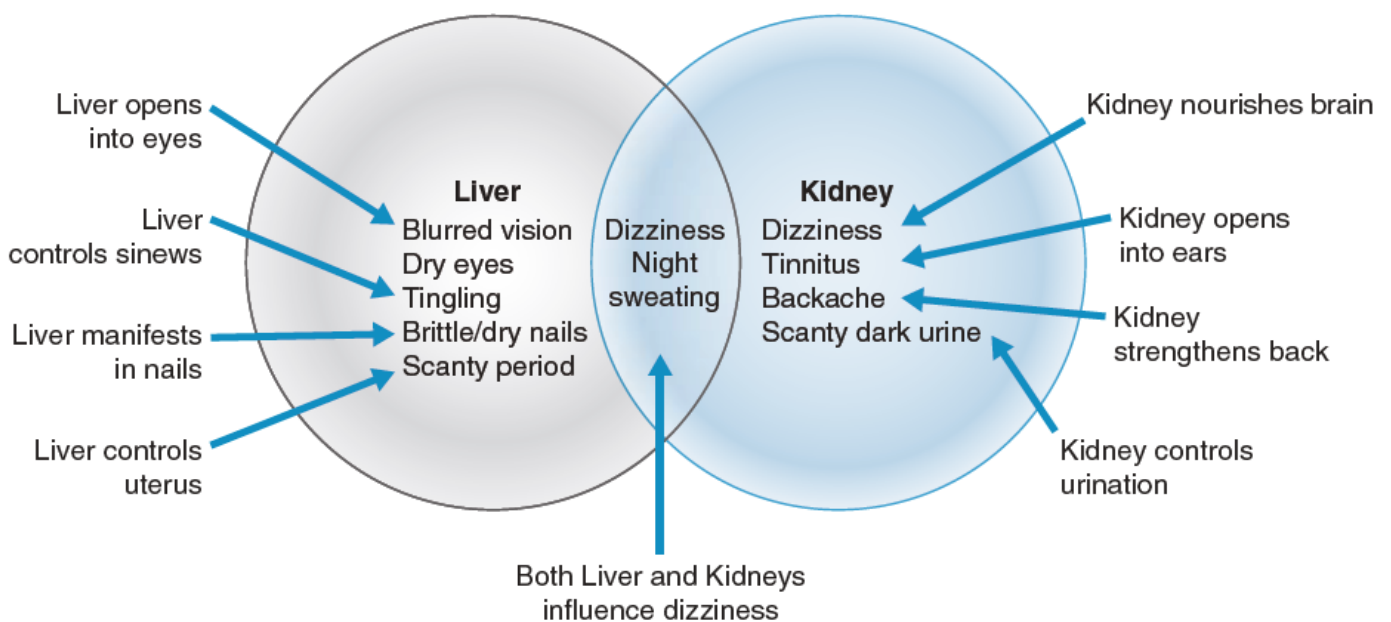


Figure 37.22 Pathology of Kidney- and Liver-Yin deficiency

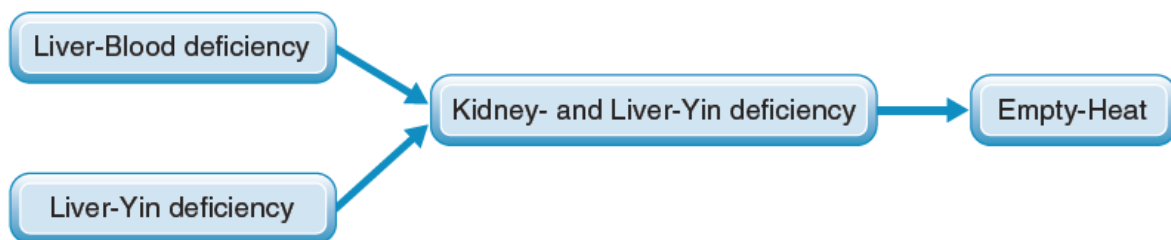


Figure 37.23 Kidney- and Liver-Yin deficiency pattern: precursors and developments

עקרון הטיפול: הזנת יין הכבד והכליות.

שיטה: חיזוק.

– KI-3 מחזק את הכליות.

– KI-6 מחזק את יין הכליות.

– LIV-8 מחזק את דם הכבד ויין הכבד.

– Ren-4 מחזק את יין הכליות, יין הכבד ותמצית הכליות.

– BL-23 מחזק את הכליות במצבים כרוניים.

– KI-13 מזין את יין הכליות.

– SP-6 מזין את יין הכבד והכליות.

– BL-10 יכול לשמש לטיפול בכאבי ראש עורפיים.

הערת הכותב על שילובים תכופים של דפוסים בכבד:

הכבד שונה במידה רבה מאיברים אחרים בכך שהדפוסים שלו מופיעים לעתים קרובות בשילובים. בפועל, אין זה יוצא דופן לראות שני דפוסים, לעתים קרובות שלושה, ולפעמים אפילו ארבעה דפוסים בכבד המופיעים יחד.

שילוב זה של דפוסים שכיח הרבה יותר בכבד מאשר באיברים אחרים.

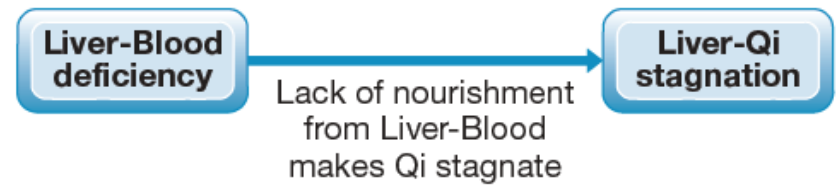
לדוגמה, זה לא נדיר לראות מטופל הסובל סטגנציית צ'י הכבד, תקיעות דם הכבד ועליית יאנג הכבד; לעומת זאת, מעולם לא ראיתי מטופל הסובל (לדוגמה) מלב-אש, סטזיס דם הלב וחוסר יין הלב.

במובן מסוים, השילוב התכוף של דפוסים שונים של הכבד הוא המקבילה הפתולוגית לזרימה החופשית של צ'י הכבד.

כמו שבמצב בריא צ'י הכבד זורם בחופשיות לכל הכיוונים, בכל האיברים ובכל חלקי הגוף, כך בפתולוגיה, זרימה זו של צ'י הכבד לכל הכיוונים ולכל חלקי הגוף גורמת להופעת מספר דפוסים במקביל.

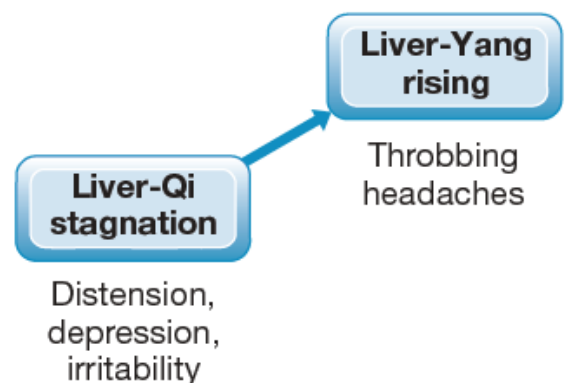
שילובים שכיחים של דפוסים בכבד:

סטגנציה של צ'י הכבד ומחסור בדם הכבד:



השילוב של סטגנציה של צ'י הכבד ומחסור בדם הכבד נפוץ מאוד בקרב נשים. הם עשויים להופיע פשוט יחד, או שמחסור בדם הכבד עלול להוביל לסטגנציה של צ'י הכבד. השניים צריכים לתמוך זה בזה **דמ הכבד הוא היין וצ'י הכבד הוא היאנג של הכבד**: השניים צריכים לתמוך זה בזה ולהתמזג בהרמוניה זה עם זה. כאשר צ'י הכבד תקוע כתוצאה ממחסור בדם הכבד, הדפוס הוא שילוב של מלאות וריקנות, והתסמינים של קיפאון צ'י הכבד קלים יותר ממה שאני מכנה "קיפאון צ'י הכבד הטהור": כלומר, כזה שנוצר באופן עצמאי ממתח נפשי. השילוב של קיפאון צ'י הכבד וחוסר דם הכבד נפוץ בקרב נשים הסובלות מבעיות קדם-וסתיות. כאשר קיפאון צ'י הכבד נובע מחוסר דם בכבד או קשור אליו, התסמינים העיקריים של תסמונת קדם-וסתית יהיו דיכאון (יותר מאשר עצבנות), בכי, תחושה של חוסר תכלית, נפיחות קלה או ללא נפיחות בשדיים, לשון חיוורת ודופק מחוספס או דק באופן כללי וקצת נוקשה בצד שמאל.

סטגנציה של צ'י הכבד ועלייה של יאנג הכבד



השילוב של סטגנציה של צ'י הכבד ועלייה של יאנג הכבד הוא שכיח. המטופל יסבול מתחושת נפיחות בבטן, דיכאון, מצבי רוח וראשים כרוניים פועמים.

חוסר דם בכבד, סטגנציה צ'י בכבד, סטזיס דם בכבד, עליית יאנג בכבד

במקרה זה ישנם ארבעה דפוסים. לדוגמה, אישה עשויה לסבול מווסת מועט, ראייה מטושטשת ועקצוץ (חוסר דם בכבד); מתח קדם-וסתי ונפיחות בשדיים (קיפאון צ'י בכבד); מחזור כואב עם קרישי דם כהים (קיפאון בכבד-דם); ו כאבי ראש קדם-וסתיים מסוג פועם עם בחילות, הקאות והפרעות ראייה (עליית יאנג בכבד)

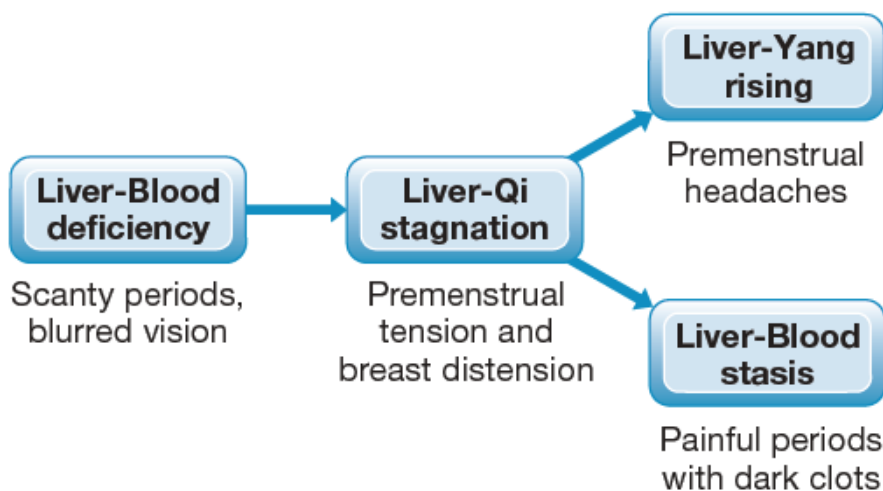


Figure 34.35 Liver-Blood deficiency, Liver-Qi stagnation, Liver-Yang rising and Liver-Blood stasis

חוסר דם בכבד, עליית יאנג בכבד, צ'י כבד מרדני

במקרה זה ישנם שלושה דפוסים. לדוגמה, אישה עשויה לסבול מבעיות עיכול עם קלקול קיבה, גיהוקים, בחילות והקאות חמוצות (צ'י כבד מרדני); עייפות, ראייה מטושטשת ושיער ועור יבשים (חוסר דם בכבד); וכאבי ראש כרוניים ופועמים (עליית יאנג בכבד).

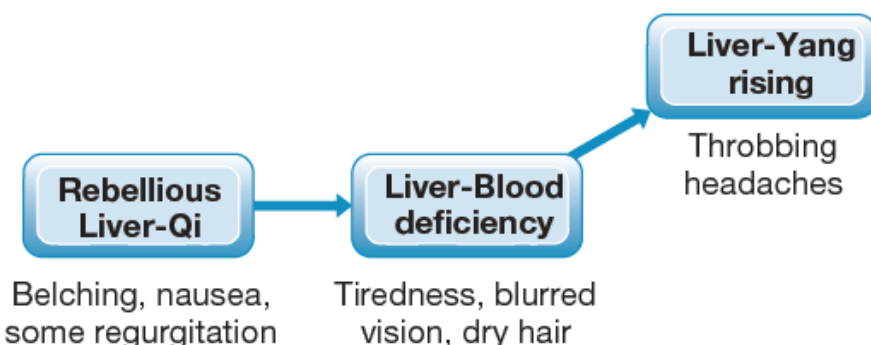


Figure 34.36 Rebellious Liver-Qi, Liver-Blood deficiency and Liver-Yang rising

צ'י הכבד המרדני, עליית יאנג הכבד

השילוב של צ'י הכבד המרדני ועליית יאנג הכבד נפוץ, שכן כאשר צ'י הכבד מרדני אופקית, סביר להניח שהוא ימרד גם כלפי מעלה. המטופל יסבול מבעיות עיכול, גיהוקים, ריפלוקס חומצי וכאבי ראש פועמים (איור 34.37).

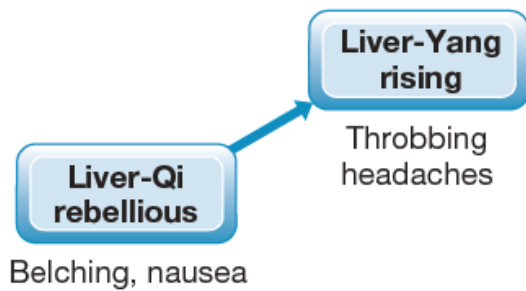


Figure 34.37 Rebellious Liver-Qi and Liver-Yang rising

סטגנציה של צ'י הכבד, אש הכבד

השילוב של סטגנציה של צ'י הכבד ואש הכבד נפוץ, שכן סטגנציה ממושכת של צ'י עלולה להוביל לחום ואז לאש. התסמינים יהיו תחושה של נפיחות, עצבנות, מצבי רוח, דיכאון (סטגנציה של צ'י הכבד) ותחושה של חום, צמא, טעם מר, עיניים אדומות (אש הכבד) (איור 34.38).

אצל נשים, השילוב של שני דפוסים אלה גורם לעיתים קרובות לבעיות שتن כרוניות כתוצאה מהתפשטות של אש הכבד כלפי מטה עם תסמינים כגון תכיפות וצריבה במתן שתן. למרות שאש הכבד בוערת באופן טבעי כלפי מעלה (ומכאן הטעם המר, הצמא, העיניים האדומות), היא עלולה גם לחדור למבער התחתון כלפי מטה, וזה קורה במיוחד כאשר היא משולבת עם קיפאון צ'י הכבד.

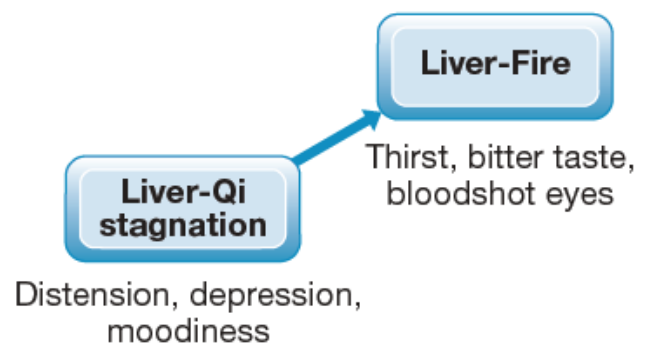


Figure 34.38 Liver-Qi stagnation and Liver-Fire